

中医临证技巧

● 周仲瑛 著

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

中医临证技巧

● 周仲瑛 著

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

中医临证技巧

周仲瑛 著

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中医临证技巧/周仲瑛著.—北京：中国中医药出版社，2021.9

ISBN 978-7-5132-7132-5

I. ①中... II. ①周... III. ①中医临床-经验-中国-现代
IV. ①R249.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第159755号

中国中医药出版社出版

北京经济技术开发区科创十三街31号院二区8号楼

邮政编码 100176

传真 010-64405721

印刷

各地新华书店经销

开本880×1230 1/32 印张2.75 字数59千字

2021年9月第1版 2021年9月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-7132-5

定价 19.00元

网址 www.cptcm.com

服务热线 010-64405720

购书热线 010-89535836

维权打假 010-64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LldUGr>

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010-64405510)

版权专有 侵权必究

前言

自新中国成立以来，中医药高等教育从无到有、从弱到强，经过一代代中医药人的不懈努力，中医药高等教育实现了跨越式发展。尤其是近年来，党中央、国务院高度重视中医药事业发展，习近平总书记在全国卫生与健康大会上指出，“要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展”，并指示“传承精华，守正创新”。

作为中医高等教育的见证人、实践者之一，我在长期从事中医课堂教学与门诊带教、教学科研与临床诊疗工作过程中，一直深感尽管有关中西医结合的举措很多，但在临床实际过程中，各地医院诊疗及教学过程中的中医药特色与优势变弱了，中医院校本科生、研究生进入临床实习和工作之后，主要精力都放在学习和掌握西医诊疗技能上，传授中医内容的授课课时较少，影响了中医药特色诊疗思维的形成与技能的提高，这是当前人才培养过程中值得反思的重要问题。

经过多年思考与临床带教实践，我认为中医院校学生临床实习带教应以中医药为主体，应坚持中医特色，加强中医知识与临床技能的培训，坚持中医特色和主体地位不能丢，要在今后的临床中起主导作用，要在临床实践中与中医理论结合起来，才能守正。在实习期间每周进行一次中医诊疗技能讲座，门诊或床边带教要结合中医理论进行讲解，不能以西医理念代替。

本书是将我既往几十年来临床带教的教学讲稿重新整理而成，旨在为今后中医临床实习带教提供借鉴。本书适用于大学本科或研究生在医院实习阶段及西学中学员在临床学习过程中使用。

周仲瑛

辛丑年夏于金陵琢璞斋

目 录

前 言

第一章 病历要求

一、格式

1.一般项目

2.主诉

3.病史

4.病案

二、病案顺序

三、病案内容

1.叙述症状

2.病机分析

3.确立治法

4.选择主方

5.用药

6.诊断

7.医嘱

8.其他

四、复诊病案

第二章 四诊的临床应用

一、四诊合参

二、四诊认症是辨证的基础

三、望诊的应用

1.色诊

2.望目

3.舌诊

四、闻诊的应用

1.听声音

2.嗅气味

五、问诊的应用

六、切诊的应用

1.脉诊

2.触诊

第三章 辨证要领

一、辨证的概念及重要性

二、辨证的主要思维方法

三、病、证、症之间的关系

四、辨证与辨病的关系

五、中医辨证的内容

1.辨病名

2.辨病因

3.辨病位

4.辨脏腑病机

5.辨病理因素

6.辨病理属性

7.辨标本关系

8.辨转归、预后

六、知常达变，掌握证的五性

1.特异性

2.可变性

3.交叉性

4.杂合性

5.非典型性

七、辨证的影响因素

1.识主症

2.抓特点

3.分真假

4.明缓急

5.定证候

6.观动静

7.影响因素

第四章 治法方略

一、立法是枢纽

二、八法是立法总纲

三、立法必须适应病情演变

四、立法要注意整体关系

五、立法必须注意个体特异性

六、常用治法的宜和忌

七、复法运用解析

1.应用复法的重要意义

2.应用复法的体会

第五章 选方要点

一、据病选方

1.大方

2.小方

3.缓方

4.急方

5.复方

二、主治方与通治方

1.主治方

2.主治方与辨证论治

3.通治方

4.几点体会

5.类方比观

三、按方随症加减

第六章 临证选药

一、熟悉常用治法和处方的代表药

二、掌握脏腑用药

1.心

2.肝

3.脾

4.肺

5.肾

三、注意随症用药

1.头痛

2.咳嗽

3.胃脘痛

4.低热（虚热）

四、结合辨病用药

五、根据经验用药

六、拓宽中药新用途

七、注意药物的主次排列

八、引经与反佐

九、中药的用量与炮制

1.关于用量

2.关于炮制

第七章 常用药物的配伍

一、同类相须

1.麻黄、桂枝

2.荆芥、防风

3.麻黄、细辛

4.川芎、白芷

5.天麻、川芎

6.苏叶、香附

7.金银花、连翘

8.黄芩、桑白皮

9.桑叶、菊花

10.栀子、丹皮（桑叶、丹皮）

11.丹皮、大黄

12.青蒿、黄芩

13.夏枯草、蒲公英

14.胡黄连、银柴胡

15.桑白皮、地骨皮

16.栀子、黄柏

17.生地黄、大黄

18.大黄、黄连

19.青蒿、白薇

20.全瓜蒌、薤白

21.石膏、知母

22.黄连、黄芩

23.知母、黄柏

24.人参、蛤蚧

25.白僵蚕、白芷

26.天麻、豨莶草

27.白僵蚕、地龙

28.苍术、厚朴

29.高良姜、香附

30.附子、干姜

31.当归、白芍（当归、川芎）

32.肉苁蓉、当归

33.三棱、莪术

34.穿山甲、王不留行

35.补骨脂、胡桃肉

36.垂盆草、龙胆草

二、异类相使

1.补阴与补阳

2.补气与补血

3.补与消

4.补与散

5.补与泻

6.补与攻

7.行气与活血

8.升与降

9.散与敛

10.表与里

11.寒与热（温与清）

12.开与泄

第八章 常用脏腑病机词汇类证辨治

一、病机的含义

二、病机的掌握

三、病机词汇在临床上的重要意义

四、本节讨论范围

五、常用病机词汇选释

1.心气虚弱与心阳不振

2.心血瘀阻与心阳痹阻

3.肺气不宣与肺失清肃

4.燥伤肺津与阴虚肺燥

5.脾气虚弱与脾阳不振（中气不足与中阳不振）

6.脾胃不和与肝胃不和、肝脾不和

7.肝气郁结与肝气横逆、肝气上逆、肝气入络

8.肝风内动与肝风上冒、肝风入络

9.肾阳不振（命门火衰）与肾气虚弱

10.肾阴亏虚与水亏火旺、相火偏旺

第九章 食养疗法

- 一、食养疗法的临床意义
- 二、食养必须注意脾胃功能的强弱
- 三、“发物”对疾病的影响
- 四、食物与药物的配合
- 五、根据疾病证候要求掌握饮食宜忌
- 六、饮食的烹调方法与治病的关系

第一章 病历要求

中医病历书写包括门诊病历和住院病历，本节重点讲中医门诊病历书写要求，住院病历另有统一要求。

一、格式

1.一般项目

初诊病历必须记录患者姓名、性别、年龄、籍贯、工作单位、地址、门诊号、初诊日期等项目，以便查考。

2.主诉

记录主症和时间（如发热、咳嗽、胸痛4天，咳吐腥臭黄脓痰1天），不应记录病名或医学专用术语（如肝炎、黄疸、鼻渊、痉挛性疼痛）。

3.病史

先记录现病史，扼要叙述病情经过，治疗检查情况，尽可能写完整。要按先后过程顺序记录。此外应记录与现在病有关的既往史、个人史等。妇女应记录经、带、产情况。

4.病案

必须体现真实性和系统性。要求在综合四诊材料的基础上，能反映出个案当前病情的症结所在；运用中医理论知识，简明扼要地阐明

脉因证治各个环节。

二、病案顺序

大体上可采用以下三种形式。

1.先叙述主症及发病时间，然后描述有关的兼症，结合舌脉，进行病因病机分析，必要时可指出本病的预后，最后立法选方。

2.先叙述有关本病的脏腑病机，结合当前主要症状、兼症、舌脉，分析其病因和病变机理，最后立法选方。

3.对某些疾病，能在舌脉上反映出辨证特点者，则可从舌脉来分析，说明病变机理特点，联系目前所表现的症状，然后立法选方。

三、病案内容

1.叙述症状

综合四诊资料，首先突出主要症状，并列举与辨证有关的兼症，应层次分明，不可颠倒凌乱（可附记重要的理化检查资料）。

2.病机分析

根据四诊资料，做出全面系统的分析，突出本病的病位和病性。阐明病理机制，邪正、寒热、虚实、表里等变化及其相互关系。并指出当前疾病的主要矛盾，以及疾病预后和转归等。

3.确立治法

在辨证的基础上，根据疾病的标本缓急，确立治法。

4.选择主方

选方必须针对立法，如果选不出适当的主方，亦可依法组方。

5.用药

须按主方的君臣佐使选药。

6.诊断

以中医诊断及证候为主，尽量做到中西医双重诊断。如有一个以上的诊断，应按主次顺序排列。

7.医嘱

如生活饮食、病情交代、服药要求等。

8.其他

如已开出的理化检查、病休证明等。

四、复诊病案

复诊病案应与前诊有联系，要突出用药后病情的改变和治疗效果、病机的转化等，最后提出当前新的判断和治疗措施。如排除原来诊断，则必须做出纠正诊断；若属新病则应做出新的诊断。

第二章 四诊的临床应用

四诊是望、闻、问、切四种诊断方法的总称，亦称诊法。四诊既是中医基本理论的组成部分，又是临床辨治疾病的基本技能。

一、四诊合参

中医理论只有通过实践，才能体现其价值，没有理论指导的实践，是盲目的实践，更谈不上自主发展和创新。

在临床中，理论与实践的磨合，需要历经一个长期积累、反复思考探索的过程，才能达到融会贯通，成为实用的知识和诊疗技能，进而推动理论的更新和发展。

立足经典，学融百家，博采众长，这是基础。综合应用多门专业知识，构建辨证论治、理法方药、证因脉治诊疗体系是解决问题的基本要素；知常达变，圆机活法是把理论转化为知识和技能的临床技巧。这样才能达到从理论、知识到技能的熟练运用。现仅以内科为主体，谈谈临证体会。

四诊是了解所有他觉和自觉症状、掌握体征的手段。在临床上必须四诊合参，综合分析，才能从多方面掌握疾病的全部情况。核实情况，排除疑似之处，防止产生片面性。

由于各个病种具有不同的特点，因此有时在全面诊查的基础上，可以凭借一种或两种诊法，掌握疾病的重点和主要矛盾。

例如水肿、黄疸，可以望而知之。进一步说，望其肿势，偏于下肢者多属阴水，湿邪偏重；面部为剧，多属阳水，风邪为主。黄疸色如橘色者为阳黄，湿热偏重；色如烟熏者为阴黄，寒湿偏重。

又如胃痛、泄泻主要是从患者的叙述中获得情况，同时也是围绕这一主症，逐步深入探问，加深认识，为辨清寒热虚实提供依据。

在脉象方面，例如典型的弦滑、结代之脉可以获得风痰和心悸（气血不足）的初步印象，腹部的切诊也可为鼓胀、癥积的诊断提供依据。

二、四诊认症是辨证的基础

四诊是认症的手段。症状仅是疾病的现象，只有认清它的本质，上升到理性的阶段，才能为辨证服务。因为有时症状表现很多，但主要病机相同，有时一个症状，又可能由于许多不同的病机产生，因此不辨清症状的本质，是不能解决实际问题的。

根据如上要求，在临床中必须以辨证的思想来指导四诊的运用，把四诊检查和八纲辨证结合起来，明确病位，分清属性，了解症状之间在病理本质上的共同性，或从某个症状所表现的病机，推断其他的可能性，扩大认症的范围，使得辨证更为全面可靠。

例如临床有恶寒、发热、头痛、咳嗽、脉浮、苔白等多种症状的一个患者，从辨证的角度分析，都属外感风寒的肺卫表证。

又如同胃痛，游窜不定的属气，固定不移的属血，喜按为虚，拒按为实，得温则减为寒，烦热灼痛为热，其机理又是多方面的。

三、望诊的应用

望诊包括望神、色、形、态等内容，但尤以色诊、舌诊为重要。

初涉临床时往往会认为问诊为四诊的第一位，难以领悟望诊的精髓，经过实践则渐能感悟到“望而知之谓之神”的真谛，而“五色诊”的启示，尤胜于望神情、望形体、望动态。

1. 色诊

色诊亦称“五色诊”。以观察面部的色泽为主，其他部位也可类推。观察面部色泽的荣枯，可以测知脏腑气血的盛衰，因为十二经脉气血皆上注于面，在病理情况下也有其相应变化。不论五色如何，其善恶的共同特点是：善者，明亮、含蓄、润泽——主表——性浮泽；恶者，晦暗、暴露、枯槁——主里——性沉浊。

同时，还当进一步联系八纲辨证，掌握病变的不同性质。例如：面见赤色，属实者为面目红赤，属虚者两颧潮红；面见青色，属寒者面色青苍，属热者面色青赤。

《素问·五脏生成》根据面色判断病人的吉凶善恶，指出：“青如翠羽者生，赤如鸡冠者生，黄如蟹腹者生，白如豕膏者生，黑如鸟羽者生。”“青如草兹者死，黄如枳实者死，黑如煤炭者死，赤如衄血者死，白如枯骨者死。”这些颇为具体。

在特殊情况下，还可根据脏腑在面部的分属，结合五色的不同，以测知某一脏腑的病变及其相互之间的生克顺逆。但应以面部整体色泽为主，分部位察色为辅，不可机械对号。确有特异表现者可参合辨析。《内经》对面部分候五脏的具体方法有二，《素问·刺热论》以额部候心，鼻部候脾，左颊候肝，右颊候肺，颏部候肾。似较《灵枢·五色》分候法简要。

白——虚	{	气虚——	晄白		
		血虚——	淡白		
赤	{	实——	面目红赤		
		虚——	两颧潮红		
青	{	寒——	青黑		
		热——	青赤		
黄	{	实	{	明亮——	湿热（阳）
			{	晦滞——	寒湿（阴）
		虚——		萎黄	
黑	{	虚	{	青黑暗淡——	阳虚
			{	焦黑瘦削——	阴虚
		实	{	黑而带黄	} 阴寒
			{	青黑相兼	

2.望目

望目是望面的一个重要方面。目为神之窗，既要观两目有神、无神，明亮、浑暗，还要注意其病理特征。目胞浮为风邪犯肺或脾虚湿蕴，目胀睛突为肝经火郁、痰瘀阻络，斜视为风火，直视、上视为痰瘀上蒙神窍，两侧瞳孔大小不等为颅脑水瘀，目睛色青而视物转动灵活多属肝旺体质，目赤充血多属心肝火盛，两目深黄多为肝胆湿热，目睛及眼睑淡白少泽多为血虚，目眶暗黑者多属痰瘀、肾虚，目睛内眦见黄色瘤斑者为痰浊瘀结。

3.舌诊

舌诊主要是观察舌体的舌质、舌苔、形态及其润燥。

由于五脏之脉皆络于舌，赖气血津液上输濡养，故通过舌诊可以直觉观察到病变所属脏腑的虚实、气血的盈亏、病邪的性质及浅深。

望舌苔要注意苔色和舌质的变化。舌质淡红为平人，淡白为气血亏虚，红绛为热盛伤阴，青紫为血瘀。苔色有白、黄、灰黑之分，白苔主表、主寒，薄白而润为常人，薄白而干为表证津伤，薄白而滑为寒湿，厚白为湿浊、痰饮、食积，腐苔为湿热秽浊上蒸。黄苔主里、主热，薄黄为邪热未盛，初传入里；黄腻为湿热内蕴或食积化热；黄而黏腻为湿浊痰热胶结；黄而干燥甚至焦黄为燥热伤津；淡黄润泽者，多为湿蕴痰聚。苔灰黑，质干者主里热，质润者主里寒；白腻灰黑，舌面湿润为阳虚寒湿、痰饮；黄腻灰黑为湿热久蕴，焦黑干燥为热极津枯。

同时，还要观察苔质的润燥，以测知体内津液盈亏和输布情况。

临证对舌诊的辨析，还应注意以下几点：

（1）根据外感内伤，分别掌握其重点。外感急性热病，重在观察舌苔，以了解病性的寒热，邪正的消长进退。内伤慢性杂病，重在观察舌质，以了解脏腑气血虚实、证候特征及病机的属性。

（2）同一舌苔，在邪正虚实寒热方面，有轻重深浅的差别，例如：舌苔白腻病属寒湿，但白腻的程度悬殊较大，必须依此判断湿邪的轻重；同一黄腻舌苔，病属湿热，如深黄厚腻者为湿热深蕴，中部聚积成腐者又有夹滞之候，若干燥少津，已有伤阴之机。

（3）判别病机属性真假。同一黑苔，如黑而润泽者为阴寒内盛，有水极似火之势；若黑而燥裂有刺者，又为热极之证。他如舌苔因食物染色而改变者，尤须加以了解，慎防由此误诊，导致辨证失当。

（4）注意病机的错综夹杂。如舌苔黄白相兼多为寒热错杂，或温邪由表初传入里，表里同病之候。舌质光淡少津者，多为正虚气阴两伤之象。

（5）舌面五脏分候法，一般以为“舌尖主心，舌中主脾胃，舌边主肝胆，舌根主肾”（《笔花医镜》）。临证虽有参考价值，但不可机械。

概而言之，舌与心胃病变关系密切，因舌为心之苗，观舌尖部位的色质，多能显示心经的病候；舌为胃镜，舌苔是由脾胃之气上蒸而生，故观苔之色质，多能显示脾胃的病候。至于肺的分属部位虽无明

确界定，如结合《伤寒指掌》胃经分候法，似当介于上脘舌尖与中脘舌中之间，上脘病涉心肺，中脘则关乎肺胃。

观察舌体形态，亦是重要的一环。察老嫩以辨邪实或正虚；视胖瘦以辨阳虚、水湿或阴血亏虚。舌有裂纹者为精血、阴津亏耗。见点刺舌者为脏腑热盛。舌边齿印为阳气虚衰、水湿内蕴。舌体暴萎为热极阴伤，久萎为气血虚衰；舌强为热盛伤阴，或风痰阻络；歪斜为内风夹痰，痰阻络脉；舌卷缩为寒凝络绌，或痰阻舌根，或热伤津液；舌体抖动为风痰入络；舌下络脉粗胀青紫为血瘀。

观察舌苔、舌质、舌态，虽各有不同的病理重点，但临证必须综合分析，方能提高辨识的准确性。

四、闻诊的应用

闻诊是通过听觉和嗅觉，了解病情，以提供辨证依据的诊察方法。

1.听声音

如果语声嘶哑，甚则失音，暴病突发者多实，久病积渐加重者多虚，或正虚邪实。谵语、狂言属实，多为痰火瘀闭；郑声、独语多属心气大伤，或气郁痰阻。喘哮病人，喘以气息急迫为主，哮以喉中痰鸣有声为主，且哮必兼喘，而喘未必兼哮。喘而痰涌声高气粗为实，喘而痰声如鼾、气怯、动则加剧为虚。少气或气少不足以息，声低不足以闻，属虚，不同于短气之气急短促，息数不相接续，两者证有虚实之分。咳嗽频剧、阵发、声高气急，多属外感实证；咳嗽轻微间作，声低气怯，多属内伤虚证；久咳致喘者，则夜卧咳剧持续不已，少气不足以息。呕吐应辨食入即吐、朝食暮吐、吐势缓急等以分虚实。呃逆声高而频作属实，声低气怯无力，断续时作多虚。

2.嗅气味

如口出酸腐臭气为胃肠积滞；口中腐臭，牙龈糜烂为牙疳；咳吐腥臭脓血浊痰为肺痈；温热病口臭喷人或汗气臭秽为疫毒炽盛；病体有尸臭味为脏气衰竭的危候等。结合辨病而言，如尿毒症的口中尿臭，肝昏迷的肝臭，糖尿病酮中毒的烂苹果味，咳吐血病者的血腥味等。但是在某些情况下，又须与望、问二诊结合进行判断，例如大小便、妇女的带下等。

当前在临证时还应采取现代相关检测手段和方法，延伸我们的感官，获取更多的信息。如用听诊器检查心肺病变、听取肠鸣音，用血压计测量血压，用影像学方法检查脏腑四肢病变等。

进一步来说，听患者诉述病情，了解其所苦，亦与闻诊密切相关。

五、问诊的应用

问诊是四诊中最需下功夫的诊查方法，也是初涉临床时的基本功。只有不厌其烦、全面深入地询问，才可掌握所有症状及其特点。

张景岳创“十问歌”，提出问诊的要领，其颇具规范性，但临证不可刻板对待。应有目的地重点探问，围绕患者主诉，突出的症状、体征，深入探询其特点，及可能发生的兼症，了解病情发展及诊治经过，以提高判断的准确性。

特别要理解中医问诊的目的，主要是为了辨证，不同于西医学的辨病。如问寒热，要问清是恶寒发热及寒热的轻重主次，还是但寒不热，但热不寒，或寒热往来，发热是壮热还是潮热、身热不扬等，以辨病位、病性。问疼痛要问清疼痛的性质，如胀痛、走窜痛、刺痛、固定痛、冷痛、灼痛、绞痛、隐痛、空痛及拒按、喜按等，以辨寒热气血虚实，从而为治疗提供重要的依据。

同时还须注重内外环境、气候、居住地区、生活及饮食嗜好、性格情绪、体质类型等与疾病的关系。针对妇女、小儿等不同对象，详察细辨。

在问诊时切忌给病人以暗示和误导，尤其与情志病人的交谈。对“诈病”者的假诉，要有所识别。

六、切诊的应用

切诊主要含脉诊、触诊两部分。

1.脉诊

脉诊非常重要，但切忌夸张到神秘不可捉摸的程度，凭脉即可知病，更不应妄自否定诊脉的客观价值。

脉诊首先应当了解如何调息，如何布指，掌握三部、七诊、九候、五十动的基本要求。掌握三部脏腑取诊法，脉与时令、个体、饮食、生活、情志的关系，正常平脉的形态等，然后才能识别有病之脉。

关于脉象的分类，一般来说有二十八脉〔浮、沉、迟、数、滑、涩、虚、实、长、短、洪、微、紧、缓、弦、芤、革、牢、濡、弱、散、细、伏、动、促、结、代、大（又作疾）〕和十怪脉。为了便于临床掌握，前人也做过不少比类、对举、归类工作，选择主要的若干脉象，作为纲脉，其中如滑伯仁的浮沉迟数滑涩六纲，也有再加虚实或短长而称八纲的。各家所说虽有出入，但是都能起到提纲挈领的作用，有利于初步从事临床工作者逐步深入掌握。

结合临床体会，尚须注意下列几点：

（1）兼脉：临床所见，脉象单见者少，兼见者多，凡属兼见之脉，必须区别主次，综合分析。

（2）脉症合参：根据《内经》所说“色脉合参”的道理，把脉象与其他症状联系考虑，互相对比，肯定问题，解决疑点，决定顺逆。既要凭脉辨证，也要舍症从脉、舍脉从症，分别真伪，认清本质。

脉诊不但要求“凭脉辨证”，认清现在症状的病理变化，还应在这个基础上，进一步了解疾病的发生发展、演变转归。例如无病之人，

脉见结代者，为“脉病人不病”，真脏之气已伤，将有暴病之变；阴证脉见沉细的病人，忽然暴出虚大脉，为阳越于外，有脱变的危机；阳证脉来洪数的病人，忽然脉转沉细，有阳病入阴的转变；眩晕患者脉见弦劲搏指者，势将内风上旋，有卒中的可能。

作为一名现代中医，既要掌握诊脉的基本操作规则、基本知识，更要在实践中加深体会，逐步提升辨识有病之脉的能力，不能轻率地认为诊脉仅是为问诊提供时间的一种形式。持上述认识者，关键在于陷入诊脉不能辨病的误区，没有把辨证作为立足点。脉的浮沉迟数，对证的表里寒热不是昭然若揭吗？

另外，诊脉辨病也有特异性。心主血脉，脉搏的原动力在心，因此，心血管系统病变，又往往能显示病变的特异性，如结代、十怪脉中的某些脉型，就能直观反映心脏病所引起的心律失常，动脉硬化者多见弦劲而不和之象等。至于湿温病初起的濡缓脉、重症病者脉快而弱的濡数脉、薛生白所说“脉无定体，或洪或缓”等，与西医学中伤寒病的相对缓脉，在辨识病的特异性方面又何等相似。

即使西医在检查脉搏有异常表现时，亦常注意描述其特征。如主动脉瓣关闭不全脉见骤起骤落者，称为“水冲脉”，这颇与中医所指大失血后的芤脉类似；因左心衰、冠心病而脉见强弱交替者，称之为“交替脉”，与中医脉诊所描述的“乍大乍小”意义类同。由此使我感悟到，对具有中医诊查特色、自成理论体系的脉诊何能轻易言玄？只有进一步应用现代手段和方法加以研究，才能有所发展提高。

2.触诊

触诊包括触胸腹、四肢、皮肤等部位，但在临床上尤以胸腹诊的意义最为重要。

（1）按胸胁：胸膺为心肺所居之处。如胸部胀满，甚至隆起，手击音清者多属肺胀，手击音浊者多病痰饮。手触虚里，搏动过剧者为宗气外泄，心气衰竭之候。两胁为肝经之分野，肝胆位居右胁，脾胰居左，若肝病癥积，脾患痞块、疟母等，则触之质硬，皆有形可征。如两胁连及腰肾区，叩触酸痛不适者，还可与肾有关。

(2) 按脘腹：脘在心下，位于上腹部，属胃所居；大腹当脐，属脾，大小肠所主；小腹在脐下至耻骨，属肾、膀胱、胞宫；小腹两侧为少腹，属肝所主。病则有相应部位的症征。

触查胸腹，一是要了解有无痞满、疼痛、包块、膨胀等，及其所在部位；二是了解拒按、喜按、怕冷、恶热、固定不移、气窜不定、刺痛、气胀、新病、久病及与饮食饥饱、二便等的关系，以辨虚实寒热气血，进而识别不同疾病的特异症状，以及妇女经带胎产情况。

从中医现代化的要求来说，还有必要从宏观走向微观，借助一些理化设备，丰富诊查手段，提高四诊水平，深化认识，既要把握疾病的普遍规律以及脏腑之间的整体关系，还要进一步认识各个不同病种的特殊表现，为辨证结合辨病提供诊断依据。

第三章 辨证要领

一、辨证的概念及重要性

辨证就是辨别、识别证候。中医的“证”相当于西医病的诊断，它是中医关于疾病发生、发展过程中把握疾病某阶段本质的一种概念。换言之，就是为了达到明确诊断而进行的思维——在全面而有重点地搜集病史、症状、体征等四诊素材基础上，运用中医基本理论，进行分析、推理，去粗取精，去伪存真，由表及里，综合判断，以得出相对合理的证候诊断，它是有关病因、病位、八纲属性、病理变化等的综合概念。其重要性正如《临证指南医案》所说：“医道贵乎识证、立法、用方，此为三大关键……然三者之中，识证尤为紧要。”时至现代，一般而言，要想应用中医药手段取得理想的疗效，仍必须有科学的、合乎逻辑的辨证思维，首先确立正确的证候。

二、辨证的主要思维方法

辨证的思维方法主要是应用中医基本理论对四诊素材进行分析筛选、分类排比。从认定主症开始，深入剖析其特点，理出证的初步线索，识别疾病的证候。以疼痛为例，要分析其部位、性质、程度、加重或缓解等因素。然后全面回顾四诊所得，扩大思路，寻求对初步印象的支持。出现不符合初步印象的证候时也要认真推敲，排除假象。主症无典型线索可辨时，可采用反面论证、逐一排除的方法。必要时还可通过试探治疗，等稍后再做进一步结论。

三、病、证、症之间的关系

首先要明确疾病、证候与症状三者间的关系。一般说，有病始有症，有症方可辨证，有证乃知病，一病或有数证，一证每有多症。症是外部表现，证是内在病机本质的时相（阶段）概括，病是证的转化沿着一定规律进行的总体轨迹。辨病（包括西医的微观手段）有利于认识疾病的个性，掌握疾病发生、发展的特殊规律，把握疾病的重点和发展趋势，有利于制定总的治疗原则，也有利于治疗没有症状的疾病。证比症深刻，比病具体，证是一种倾向于重点揭示某一阶段特定人体病理生理功能状态的综合性诊断概念。故曰病不变而证常变，病有定而证无定。不同的病可有相同的证，但又同中有异。总之，病、证、症三者既有区别又有联系，临床时必须处理好它们之间的关系，一般是在分析症状的基础上认识疾病和辨别证候，在识病的同时辨证，辨证是中医理论指导临床治疗的核心，是灵魂。

四、辨证与辨病的关系

中医学对许多疾病的诊断均以证为名，反映了辨证论治的诊疗体系和同病异治、异病同治的基本精神。证在横的方面涉及许多中医或西医的病，如咳嗽就是感冒、哮喘、肺癆、肺胀等多种肺系疾病常见的主症，胃脘痛是溃疡病、胃炎、胃痉挛、胃下垂等病的主症。通过辨证就能突出疾病的主要矛盾，给予相应治疗。尤其在辨病较困难的情况下，有时可通过辨证取得疗效，解决问题。因此，不可简单认为以证名病无明确概念和范围，难以表明病的特异性，而转向单一的辨病诊断。

此外，必须明确中医学自身的病名诊断。根据四诊认证、辨病，分析内在病变机理，确认病的特异性及其发展转归，为施治提供依据。但是，这些又不完全与西医学之辨病治疗相同，因为它既要针对某个病的共性及基本规律进行治疗，又要结合个体及不同证候分别处理。由此可知，中医学的“辨病论治”与“同病异治”，两者还有相互补充的关系。如肺癆的治疗主法为补虚杀虫，但还需辨证予以滋阴润肺、滋阴降火、益气养阴等法，这就体现了辨病与辨证的有机结合。反之，不同疾病在同证同治时，也应针对各个病的特殊性而区别对待。此为同中求异，异中求同。

再者，在辨病的要求上，还有一个西医学的病名诊断问题，它与中医的以证名病可相互补充。辨证治疗可补充辨病之不足，辨病有助于掌握不同疾病的特殊性及其发展、转归，并结合病的特异性进行处理。但这种双重诊断只可并存，而不宜对号入座、生搬硬套。如胃脘痛不单出现在溃疡病，而溃疡病也不仅以胃脘痛为主症，还可见吐血、呕吐。当然，在大量临床实践基础上，也可通过适当对照联系，使中西医之部分病名相互沟通，以趋于一致。同时，还应汲取西医学的部分病名，补其不足，为我所用。如肿瘤、流行性出血热、白血病等，在掌握西医学基本概念的基础上，通过临床实践，将其上升到中医理性认识的高度，总结出辨治规律，使之适应医疗实践的需要。

总之，中医的辨证和以证名病，与其自身理论体系和临床实际密切联系，但同时也有辨病要求。那种中医只有辨证，而辨病仅是指西医病名诊断的认识，是不够全面的。我们应防止以西套中、以西代中的倾向干扰中医的临证思维。

五、中医辨证的内容

1.辨病名

根据中医有关病名的认识，抓住主症（可有一个或若干个）及其临床特点，确定可能的病名尤其是非症状病名，这有利于针对疾病特点进行分别治疗。如有些病在一定阶段都可表现为脾胃湿热证，但黄疸宜用茵陈蒿汤，湿温宜用王氏连朴饮、甘露消毒丹，泄泻宜用葛根芩连汤，痢疾则宜用芍药汤等。这些方药的治则虽然基本相同，但对病的针对性是有差别的。

2.辨病因

病因是疾病的始动因素，病机是发病后的演变转归。辨病因是根据中医有关病因的理论，根据发病的季节、环境，发病前后的有关因素，生活习惯等，推理而得，或从证候表现以“审证求因”，作为病理

分析的基础，结合病程新久，分清外感或内伤的类别，以决定采用哪一种辨证方法（如六淫、卫气营血、六经或脏腑经络、气血）。同时，疾病又是病因与机体相互作用的结果，了解病因对治疗有直接的意义（针对病因治疗，如虫积内扰的要驱虫、癆虫蚀肺的要抗癆）或间接的意义，要及时消除病因造成的病理后果。如郁怒可以伤肝，肝病可能出现肝气、肝火、肝风等病理转归，治疗可分别采用疏肝理气、清肝泻火、平肝息风等法。

3.辨病位

根据中医病位的认识（如表里、卫气营血、脏腑、经络等），从证候表现判断病变所在，了解涉及的有关脏腑，有利于进一步分析病机，并可提供“归经”用药的依据，使同类药物的选择提高了针对性。如火盛所致出血，“咳血——肺热——黄芩、知母、桑皮、地骨皮”，“吐血——胃热——生石膏、黄连、地榆、生地黄”，“便血——肠热——槐花、地榆、荆芥炭、侧柏叶”，“尿血——肾、膀胱热——黄柏、瞿麦、大蓟、小蓟”等。

4.辨脏腑病机

根据中医有关脏腑、气血等生理功能和病理变化的理论，抓住临床表现，分析综合证候的发生机制，了解脏腑、气血失调状态下的病理演变，可以掌握证与证之间的转化规律，对指导当前治疗和制定下一步诊疗计划有重要作用。

如外感咳嗽可表现风寒袭肺、风热犯肺等证，但肺除主气、司呼吸、调节卫气外，尚有通调水道、治节血脉等功能。若邪壅肺气，肺失通调，可以出现水肿病。如反复感邪，久咳迁延，损伤肺气，肺失治节，可以发展为咳喘、痰饮，后期并可导致心血瘀阻之证。

总之，一个脏（腑）有多种生理功能，一种疾病可以只涉及其中一种功能失常，也可在同一阶段或不同阶段表现若干种病理生理变化，复杂的疾病涉及多种脏器，则可有更复杂的病理生理改变。

5.辨病理因素

根据中医有关病理因素（如痰、饮、火、瘀等）的理论，抓住某些证候表现（包括可见的病理事物与临床特征）推理而得。病理因素不仅直接致病，还可以在疾病过程中因果相承，促使病情日趋恶化。因而了解病理因素，对消除它的存在进而切断疾病发生、发展的因果交替环，促使疾病痊愈，有重要意义。

值得强调的是：辨证必须以脏腑病机理论为主导，根据主要症状体征，把握病机所属，辨清病理因素及其多元复合关系，以病机证素为辨证的客观依据，使辨证更加灵活化，切合临床实际，不致成为僵化的教条。

为此，笔者提出“脏腑病机辨证十三条”新说，作为辨证的要领，病机证素的论据，明确病位、病性，提供证候要素的特征，为治疗指明方向，从而构建成中医病机辨证因果链。概要言之，“病机辨证十三条”的要领是：风病善变，寒多阴伏，火热急速（温暑同类），湿性缠绵，燥胜伤津，痰证多怪，水饮同源，瘀有多歧（血病多瘀），郁病多杂（气病多郁），虚病多久，毒多难瘥，疫为戾气，多因复合（风火相扇、瘀热相搏、寒热错杂、湿遏热伏、痰瘀互结、邪实正虚、多脏同病）等。如能据此列其常见证候内涵，必将有助于构建新的辨证体系。

病机要素因果链体现疾病的发生、发展传变规律。如风为百病之长，六淫之首，善行数变，常夹他邪伤人。土为万物之母，性无定体，随五气而从化。风木之病属肝，湿土之病属脾。风能长养万物，土为生化之源，故以风湿为切入点。

肝失疏泄——肝气郁结——肝郁化火——火动风生——风助火势——火借风威——风火交扇——风动痰升——痰因火动——毒因邪盛——寒从火化——燥为次寒——痰湿酿热——痰瘀互结——风痰入络——久病多虚——气阴耗伤——多因杂合。

6.辨病理属性

根据八纲辨证的理论，抓住证候特点推理、综合而得。八纲是中医认识疾病性质的一种最基本归类法。除表里两纲属于病位外，不同疾病可以表现阴阳寒热虚实的共性，同一疾病在不同个体和不同阶段也可有寒热虚实不同演变，且多交叉复合为病。了解疾病的八纲属性，是确定同病异治和异病同治的关键。

如肺癆、咳嗽或风温后期表现肺阴不足证，均可采用滋养肺阴的方法。又如哮喘病风痰伏肺是其核心病机，但在不同阶段及不同的个体可有不同的病理属性，发时多属邪实，当辨寒热，分别治以温化或清化，平时多属正虚，当辨肺肾气虚抑或阴虚，治以温养或滋养。

7.辨标本关系

根据中医的标本理论，对有关因素及矛盾进行分析，找出那些在疾病全过程或某阶段中决定疾病进程、影响全局的主要环节，正确把握各种因素之间的联系与转化。这对治疗复杂疾病（即存在复合病因、多病位、多种病理生理改变、多种病理因素以及对立的八纲属性等），解决主要矛盾，恰当处理次要矛盾，提高疗效，起着主要作用。故《内经》有“不知标本，是谓妄行”“知标知本，万举万当”的说法。

8.辨转归、预后

在以上多方面分析的基础上，根据中医疾病学的知识和经验，并参考西医学的有关知识，结合病变过程中出现的重要症状、体征，做出以下两方面初步估计：①疾病的转归，在发病学对预防和治疗上有一定意义（如懂得肝病可以传脾，则不但治肝还可实脾）。②疾病的预后，便于及时采取措施。

以上是我们在辨证分析中需要认真把握的内容，但必须说明：根据以上的某个项目，可能不会得出完整的结论，如病因和病名偶有难以明确的情况，同时在临床应用时，各个项目的重要性及其主次作用也可因病而异。

六、知常达变，掌握证的五性

证的五性即特异性、可变性、交叉性、杂合性、非典型性，掌握证的五性对于提高认证的精确度、加强辨证的预见性大有裨益。

1. 特异性

每一个证都有其特殊内涵，即特异性。但从组成证的各种症状和体征看，其中不少既可出现在本证，也可出现于他证，并非均有特异性。在临证中，要特别重视组成此证的特异性症状和体征，以及这些特异性症状、体征的特异程度和数量。临床实际所见之证，也存在特异性程度的差别。对特异性程度较低证的治疗也不能忽视。如外感少阳证，须具备口苦、咽干、目眩、往来寒热、胸胁苦满、脉弦等症。分解来看，往来寒热的特异性价值明显高于其他，临床即使有口苦、咽干、目眩、脉弦等数症也不能轻易诊断为少阳证。如曾治一例杨姓肝癌患者，肝功能异常，肝脏肿大，腹水明显，笔者抓住患者舌质光红无苔、口干少津这一特异现象，重用养阴的生地黄、天冬、麦冬、玄参、鳖甲等甘寒、咸寒药，伍以清热解毒、凉血化瘀之品，水消胀缓。据症化裁，前后服药两年，肝功能正常，随访5年仍然健在。

2. 可变性

证是具有时效性的诊断概念，随着时间推移，证与证之间可以相互转化，相比而言，证较西医病的时效性要强烈得多。在急性病中，证旦夕可变。即使是慢性病，随着患者的体质内环境、治疗等外在条件的不同，也可错综演化。在许多情况下，注意掌握证势、病势，对证的可变性也是可以预见的。

所谓证势，即指一种证向另一种或若干种证转化的通常趋势。如肝气郁结可化火、生痰，故气郁证每多转化为气火证、痰气郁结证等。在外感疾病中，卫分证可向气分证传变，气分证又可向营分证、血分证传变等。但因证势在很多情况下尚不足以决定疾病转归，故探

求病势的问题必须兼顾。所谓病势是证势的特殊规律，即指一些疾病，证的转化有自己的特殊趋势。如肺癆病的肺阴不足证往往出现在初期，而风温病的肺阴不足证则多见于恢复期。

3.交叉性

交叉性即两类以上证候的互相联系、并见。其交叉组合形式多样，在八纲辨证方面，如气血两亏、寒热互结、表里同病；在脏腑病位方面，如肺肾阴虚、肺脾气虚；在病理因素方面，如气滞血瘀、湿热内蕴、痰瘀交阻等。其辨治要点是确定两者的轻重缓急，以明确治疗的主次先后。有的应抓病变重点，如肺肾阴虚重在治肾，肺脾气虚重在治脾。有的应抓病机主次，如气滞血瘀之胁痛，气滞突出用柴胡疏肝散，血瘀明显时用复元活血汤。如《伤寒论》治疗痞证之半夏、甘草、生姜三泻心汤，因属寒热错杂，故既用苦寒泄热的黄芩、黄连，又配辛温散寒的生姜（干姜）、半夏。

4.杂合性

所谓杂合性即指两种或两种以上的疾病并存，并由此产生两类或两类以上的复合性或杂合性证。其辨治要点是把握标本主次，或标本兼顾，突出重点，或遵“间者并行，甚者独行”的原则论治。如病人同时有胃脘痛、失眠，证属肝胃不和、湿热中阻、心肾不交，治疗当根据病人的具体情况，或以疏肝和胃为主，或以清化湿热为主，或以交通心肾为主，或三者同时兼顾，总之，要把握标本，分清缓急。

5.非典型性

非典型性是指证应该出现的特异性症状在数量和程度上表现不足，即没有常见的典型症、征。对于证的非典型性的辨识，应注意证的发生、发展、转归的全过程，把握初期性证、过渡性证、潜伏性证与轻型性证，避免辨证的局限以及用药的浮泛。

(1) 初期性证：指疾病初起始得阶段病证特有的症状尚未显现，缺少特异性。如风温、悬饮、肺痈初期均可有风热犯肺证的过程，若不从发展趋势深入分析，不结合辨病，统予疏风清热宣肺，必然针对性不强，难以阻止其发展。

(2) 过渡性证：又叫临界性证，是病情由一证向另一证转化发展过程中出现的似此似彼的证候。如中风虽无明显昏迷，仅见半身不遂、口角歪斜，但神识时清时昧者，为介于中经络和中脏腑间的证候，似可称之为“半经半腑证”。这种情况神志既可由昧转清而表现为中经络证，也可进一步发展至内闭神昏而见中脏证。如笔者曾治一例顽固哮喘患者，表现为典型的小青龙汤证，药后缓解，而背寒易汗气短，转为肺气虚寒证，经从本治疗稳定。逾年复发，服温化剂不效，再审其烦躁，唇起火疮，舌质较红，乃在小青龙汤基础上加石膏服之喘止。这说明寒饮伏肺证既可转见虚寒，亦可寒郁化热。据此可知，必须及时抓住病机演变趋势，予以相应治疗。

(3) 潜伏性证：又叫“潜证”，其特点是临床症状极少甚至无证可辨。对此需注意从病史、舌、脉、体质、个性、喜好等细微处探索，并借助理化检查结果，参照疾病的基本病理进行辨证论治。如哮喘处于缓解期时，只有凭借病史及一般情况推测其发时证候，按照“平时治本”的原则立法选方。通过治疗潜伏证而达到防止或减轻发作之目的。

(4) 轻型性证：是由于症状严重程度不著，存在质的差异而缺乏典型表现。如有些肺癆患者肺阴虚证不重，仅有轻微咳嗽，或略觉乏力；又如高血压病之头痛、眩晕程度不著；再如冠心病之胸痛血瘀证不显，仅偶感胸闷等。临证对轻型证候亦不可忽视，因它虽然反映病情轻浅，但也可能成为严重疾患的不典型表现，仍要高度警惕，仔细辨析。

另外，证是客观存在的，但在临床上我们面对患者凭主观印象所辨得的具体证是否与客观证相符合，则需要慎思。因为我们的辨证依据有时过分依赖主诉症状，少数可供参考的体征如脉象、舌象也可能接近正常或不具有特异性。

从患者的角度分析，主诉是患者受主观感觉到的，患者的耐受性、表达能力各有不同，还有各种社会、心理因素可以影响或扭曲主诉；对医生来说，认症问题也有一个敏感性和标准化、客观化问题，

如舌是否红、是否紫，脉是否弦、是否滑。故临床所辨得的证，不可否认存在客观性强弱的问题。一个证候（尤其是主症）出自主诉，还同时得到其他三诊（望、闻、切）的支持，甚至微观检查的证实，则提示客观性强。如主诉心悸而切诊脉律失常，听诊心音或心律有异，心电图、超声心动图等亦有阳性改变等，而由较多客观性强的症、征形成的辨证，自然客观性也随之增强，反之就较弱，可信度降低。对后者适宜小剂、轻剂试探，不必用重剂、峻剂。

七、辨证的影响因素

初接触临床的医生在辨证时遇到的困难，绝大多数是不熟悉辨证分析的基本要点，其中某些要求实际上是在四诊过程中就开始的。

1. 识主症

首先应确定主症（一个或若干个），因主症往往反映疾病的主要矛盾，故必须抓住，才能有助于得出相对合理的病、证诊断。一般根据患者就医的主要痛苦，主症是容易确定的。但如遇到下面的一些实际问题时，还应当结合现代理化检查知识加以分析：

（1）没有主症：如健康体检中，X线检查发现肺部有轻微结核病灶，或普查肝功能发现转氨酶偏高，乙肝表面抗原阳性等，这是辨证论治面临的新问题。

（2）主症多端：没有重要的实质性病变，而主观痛苦多端且多变，令人难以捉摸，如神经官能症之类。也有多种器质性病变，确实存在多种痛苦，而患者本身难以确定主次。

（3）主症与兼症混淆：在疾病的主要矛盾与患者的主观痛苦不一致时，易出现主次不清，甚至将主症遗漏的情况。如非典型的黄疸，忽略了目黄、肤黄、溲黄等症，多主诉食少、无力或低热等，易将此当成主症。

2.抓特点

围绕主症，深入了解其特点，推动四诊的深化，这对明确诊断，辨清病理因素、病位、八纲属性等至关重要。

3.分真假

联系对照主症与一般症状、体征所提示的病理线索，若彼此相符者，属单纯或典型的病例，诊断较易。若彼此矛盾，则当考虑是否有假象存在，是否是疑难杂病，是否是复合疾病。必须仔细复查和推敲矛盾的主要所在，区别真假，决定取舍。

4.明缓急

初步考虑为疑难或复合疾病者，可按各个（或各组）症状发生时间的先后与演变，探索可能存在的因果关系，评估各个（或各组）症状的特异性，权衡主次轻重缓急，为决定治疗提供依据。

5.定证候

根据全部四诊资料，按辨证的内容项目进行分析、推理、综合，找出共性，掌握这些现象内在的病理联系，确定其证候类别。

6.观动静

辨证有时还应通过对疾病过程的动态观察，治疗后的效应，进行必要的修正、补充，以提高疗效。在分析和综合的过程中，应力求避免主观性、片面性与表面性，肯定和否定某种结论都要注意思维逻辑的严密性。

7.影响因素

为了提高辨证的水平，还应着重探讨一下影响辨证质量的因素。初步归纳有以下四个方面：

（1）辨证的素材：四诊资料的不足或遗漏、失真，包括：病人症状、体征的缺乏，各种原因造成疾病性质的不典型；无法了解病史（如病人聋哑、痴呆、健忘、昏迷）；病人伪造病史及症状；环境条件的限制；时间仓促影响诊查质量；医者主观上的马虎、草率、责任心不强等。

（2）辨证的能力：中医基本理论，特别是脏腑辨证、卫气营血辨证、病邪辨证以及疾病学、症状学的知识掌握不够，知识的广度、深度不足，缺乏临床实践经验等。

（3）辨证的思维方法：思维主观、片面，不熟悉辨证分析的逻辑方法，在素材加工由此及彼、决定取舍的过程中导致结论错误。

（4）辨证的表达：词不达意，虽有认证的能力而不能在辨证分析中准确和全面地反映，致使辨证不准确。

最后还要指出，这里讲的辨证质量标准，是在中医的思维逻辑与经验范围内而言，由于辨证的依据主要是症状、体征，目前还不可能完全凭借现代科学技术和方法，提供客观检查指标（如理化检查、特殊仪器检查、病理形态学检查等），故确定辨证分析的质量（水平），通常只能从治疗效果反证，而两者之间又不是绝对一致的。一般来说，结合现代诊查辨病的技能和方法，有助于提高临床辨证分析质量，总结辨证规律。

第四章 治法方略

中医辨证论治分两步骤，先是辨证，后是论治。临床既要掌握治疗疾病的总原则，如平调阴阳，治标与治本，扶正与祛邪，防治未病，正治与反治，因时、因地、因人制宜等，还应在治则指导下，掌握治法的具体应用，才能符合实际需要。

一、立法是枢纽

没有正确的辨证，就没有正确的治法，如果不懂得从辨证考虑立法，就不可能确定有效的治法。另一方面，立法又是处方用药的根据，没有立法作为指导的处方和用药是盲目的。如果立法正确，虽然选方用药不完全相同，也可取得同样的效果。

一般而言，辨证是立法的依据，如寒者温之，虚者补之。但在证与治之间，有时也可出现不一致性，这与证的轻重、兼夹、变异等有关。如风热表证，用辛凉法时，有轻剂、平剂、重剂的不同。湿热痢夹表证，应先予逆流挽舟法以解表，而不是先用清肠化湿；若热毒内陷，由闭致脱者，必须先救逆固脱，然后再清肠解毒等。

从中医学理论体系扩大立法思路，多途径寻求治法尤为重要。如按阴阳气血的转化互根立法，按五脏的相互资生制约立法，按邪正虚实消长及其主次立法，按疾病的动态演变立法等。益气生血、行气活血、滋肾平肝、攻补兼施、肝病实脾、肺实通腑，以及所谓隔二、隔三治疗等，都是在这种思路下确立的。

二、八法是立法总纲

在八纲辨证分类基础上，相应地确定了立法的总纲——八法。临证首先应当掌握八法这一基本规律，然后才能根据病情的具体表现而

灵活应用，按照八纲证候的单纯或复杂情况，采用单一或综合的治法，由此达到“一法之中，八法备焉，八法之中，百法备焉”的化境。

三、立法必须适应病情演变

对任何一个疾病，在它转化及发展的过程中，其治法亦应做到以变应变，决不可执一法一方以应万变。转化，是指某些疾病，在其病变过程中，可能发生的病理演变，但不是必有的发展规律。

四、立法要注意整体关系

根据中医学理论扩大立法思路，多途径寻求治法尤为重要。

从阴阳气血相互关系立法：在补阴时，于阳中求阴；在补阳时，于阴中求阳；补血时，用补气生血法；补气时，用补血益气法；气滞血瘀者，并用行气与活血法。

从五脏资生制约关系立法：相生，如补火生土、培土生金、滋水涵木等；相克，如抑木扶土、崇土制水、壮水制火。其他，如下病上取、上病下取等。

从邪正虚实之间关系立法：衡量患者邪正虚实的主次，决定攻与补的先后、主次。

五、立法必须注意个体特异性

如汗法用于体虚者可参补药；补法对“虚不受补”者当参以行气药；清法对脏腑虚寒之体，应中病即止；温剂对阴血不足之体，要慎用；消法对本虚者不宜独用等。

六、常用治法的宜和忌

医生要从正反两个方面了解常用治法的宜和忌，做到正确运用，适度使用，以免伤正或助邪。如用汗法应该注意“汗而毋伤”，亡血、产后、淋家，一般均当忌用；涩法对新病有邪者忌用。

治法是选方组药的依据，理应做到方随法定、药依证选，但因临床每见证候交叉复合，表里、寒热、虚实错杂，多脏传变并病，为此，有时还需复合立法，方能适应具体病情，取得较好的疗效。尤其对多病多证的患者，还应按辨证做到主次有别，在针对主病主证，采用某一主法的同时，又要把握其整体情况，注意兼病、兼证，复合立法，兼顾并治。

即使单一的证，有时也需通过复合立法，求得相互为用，以形成新的作用，消除一法所致的弊端，如纯补滞气、寒热格拒等。

在应用复法时，势必随之形成大方、多药。按一般通常要求，方药应该精练严谨，但在病绪多端，复合应用多法组方配药时，大方多药，又不应加以非议和排斥。大方为七方之首，药味多是其特点之一（还有药力猛、药量重等），适用于病有兼证，尤其是疑难杂症患者。但必须做到组方有序，主辅分明。选药应各有所属或一药可兼数功者，尽量处理好药物之间相须、相使、相畏、相杀的关系，避免降低或丧失原有药效。切忌方不合法，主次不清，药多杂乱无章。

七、复法运用解析

复法就是复合立法，主用于证的交叉复合，有时单一的证也需通过复合立法，求得相互为用，以形成新的作用，如温下法、酸甘化阴法等。此外，还可借复法取得反佐从治，或监制、缓和其副作用。

1.应用复法的重要意义

（1）错综配伍，各奏其用：体虚者，纯补则邪愈恋，纯攻则正愈虚；寒热错杂者，单用寒药除热则寒益甚，用热药除寒则热者更热。因此，临床中必须复合为法，以求发挥各类药物的专长，使虚得

以补，实得以泻。如汗下并用，温清并用，攻补兼施，消补并用，寒热补泻并施等。

(2) 配合立法，相互为用：按照立法要求，将两类不同性味功效的药物配伍组合，以形成新的作用，如温下法、交通心肾法、酸甘化阴法、甘苦合化法等。根据立法需要，选用某类药物，缓和另一类药物的副作用和毒性。如补中寓泻、泻中寓补等。

(3) 错综立法，取得反佐：凡治疗寒极或热极之证，用少许相反的药，可以起到从治诱导作用，避免格拒。

采用各种复法，必须有主有次。

2.应用复法的体会

(1) 升降结合：升降是人体脏腑气机运动的一种形式。人体脏腑气机的正常活动，维持着人体正常的生命活动，如肺气的宣发与肃降、肝气的升发与疏泄、脾气的升清与胃气的降浊、肾水的上升与心火的下降等，都是脏腑气机升降运行的具体表现。临床所见气机升降失常的表现很多，如肺失宣肃、肝失疏泄、心肾不交、脾不升清、胃失和降等，但其病理变化不外升降不及、太过和反常三类。升降不及是指脏腑虚弱、运行无力，或气机阻滞、运行不畅。如肺虚之咳嗽无力，脾虚之便溏、头昏、乏力，肠腑气虚之便秘等。升降太过是指脏腑气机的升降运行虽然与其正常生理趋势一致，但却已超过正常程度，如肝气升发太过之肝阳上亢，肝火上炎之眩晕、头痛、目赤等，肠腑、膀胱气机泄降太过所致之泄泻、尿频失禁等。升降反常是指脏腑气机升降运行与其正常生理趋势相反，亦即当升不升而反下陷，应降不降而反上逆，如中气下陷之泄泻、脱肛、阴挺、内脏下垂，胃气上逆之呕恶、暖气、脘胀，心肾不交之心悸、失眠等。临床以升降反常的病证为多见，其治疗非单纯升清（阳）或降逆所能奏效，必须升降并用，以达到调整人体气机升降紊乱，使之回复正常的目的。

(2) 阴阳互求：阴和阳在整个病变过程中，关系非常密切，一方虚损，往往可导致对方失衡，阴虚及阳，阳虚及阴，最终演变成阴阳两虚者。其治疗固需阴阳双补，而单纯的阴虚或阳虚，亦要从阴阳互根之义求之，尤其对肾虚病证更有实用价值。此即张景岳所云：“善

补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷；善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭。”临床在治疗中风后遗症、糖尿病、慢性支气管炎、阳痿、水肿等疾病时，往往体现阴阳互求的重要性。

（3）补泻兼施：补法是指补益人体气血阴阳的不足；泻法从广义上说是指祛除客犯于人体的各种病邪。内伤杂病虽多，然其要不外虚实两端。《素问·通评虚实论》云：“邪气盛则实，精气夺则虚。”虚实是邪正盛衰在临床表现上的具体反映。邪实是指侵入人体的外感六淫，或由气化障碍所产生的水湿、痰饮、湿热、瘀血等病理产物以及脏腑气机失调所产生的气机阻滞等；正虚，原发于先天者因禀赋不足，继发于后天者是因各种致病因素的长期影响，以致气血阴阳津液精髓不足。一般来说初病多实，久病多虚。然而由于人是一个极其复杂的有机体，邪正虚实往往错杂相兼，初病未必就实，如虚体感冒，治当扶正解表；久病亦未必就虚，往往伴有气滞、痰饮、水湿、瘀血等。例如慢性肝炎既有疲劳乏力、腰酸膝软、口干便溏等肝脾肾俱损的征象，又有胁痛、脘痞、尿黄、纳差、目赤、口苦、口臭、舌红苔黄腻、脉弦滑等湿热瘀毒互结之表现。治疗当视其虚实程度，泻其实，补其虚。

（4）寒热并用：寒证与热证，多系脏腑阴阳失去平衡而产生的临床表现。各个脏腑之间的寒热表现各有差异，或一脏有寒、一脏有热，或同一脏腑既有热象又有寒象。临证时不可不详细辨别，如肝热脾寒之泄泻、痢疾，肾阳虚寒、痰热蕴肺之咳嗽、哮喘，或寒热互结之痞证、胃痛等。尤其是中焦脾胃疾病，即使无明显寒热夹杂之象，但采用辛温与苦寒合法，按主次配伍，每能提高疗效，如半夏泻心汤合左金丸之治胃痛等。

（5）敛散相伍：适用于病情复杂之证，如既有气阴耗散或卫阳不固，又有外邪客表或气机郁滞或内热郁蒸等表现。故治疗既需收敛固涩，又需疏散外邪或行气解郁或清中泄热。如慢性腹泻属脾肾两虚，同时兼有肝气横逆者；慢性咳嗽、哮喘，既有痰伏于肺，又见肺气耗散者。

（6）表里相合：表证和里证可以单独出现，亦可兼见。表里同病者表里双解，此乃常规，但对内伤杂病里证的治疗适当配入表散之品，也可以达到调和表里、提高疗效之目的。如在治疗水肿、头痛、

眩晕等疾病时，可以在辨证施治的同时加入羌活、防风等疏风解表药。若为“阴水”致肿，配用疏风解表药也可起到“风能胜湿”消肿的作用；内伤性头痛、眩晕，配用风药引药上行，则是基于“颠顶之上，唯风可到”的认识。

（7）气血互调：气与血是人体生命活动的重要物质基础，相互资生为用，多互为影响为病。气与血的不足，失于温煦、濡养，固需益气以生血，或补血以益气，然在补气血药中，参以活血行血，更有助于增强疗效。至于气与血运行失常所致的病变，尤当注意气血互调，如治疗咯血、吐血、咳血，除针对病机辨证止血外，表现有气滞、气逆者，还应注重行气、降气药的应用，配青皮、沉香、枳壳、香附、川楝子等；在治疗郁证、胃痛、胁痛等气机郁滞一类疾病时，亦应重视血分药的运用，配伍川芎、赤芍、丹参、失笑散等。

（8）多脏兼顾：五脏互为资生制约，脏与腑表里相合，病则互相影响。故治疗不仅要按其相生、相克关系从整体角度立法，有时还需两脏或多脏同治，把握疾病传变的规律，采取先期治疗，如肝病当宗“见肝之病，知肝传脾”之意，肝脾同治。切忌顾此失彼，忽视因果关系，只看表象，不求本质。

综上所述，按照复合立法的思路组方用药，不仅可以适应疾病的复杂性，即使单一性质的病变，亦有助于提高疗效。临证有时还常需数法联合，用以治疗多病多证杂见的病情，正如《素问·异法方宜论》所说：“杂合以治，各得其所宜，故治所以异，而病皆愈者，得病之情，知治之大体也。”

第五章 选方要点

临床按病辨证选方，是切实掌握好“辨证论治”的重要一环，正如清代名医柯韵伯所说：“因名立方者，粗工也；据症立方者，中工也；于证中审病机，察病情者，良工也。”要想开好一张处方，首先要掌握辨证论治的基本知识，系统地学好中药学、方剂学及临床各科知识，这些都是必不可少的基本功；其次还应掌握有关处方的基本知识，逐步熟悉从识方、用方到制方的步骤。

一、据病选方

这里所指的病，是指总的病情；所指的方，也是指总的处方规律。《内经》云：“病有缓急，方有大小，知所先后，则近道矣。”这就强调了病情和处方必须两相符合。一般来说，总的病情可分为五，即大病、小病、缓病、急病和复（杂）病。而处方相应的亦有五，即大方、小方、缓方、急方和复方（此外，古代尚有“奇方”和“偶方”，共称“七方”。但奇、偶二方，单从药味数字上定名，临床意义不大）。这样就可根据总的病情，确定五种不同类型处方用药的轮廓。

1.大方

病情较重的叫大病，适应这些病情的处方要大，药力强，药量重，服药次数间隔短，企图即时取效，这就叫大病用大方。若大病而用小方，显然是杯水车薪，无济于事，等到病情已见败象，那就失去最好时机了。

2.小方

病势较轻，全身反应不显著的叫小病（当然，小病不治，也可酿成大病），处方时应采用药味少、药量轻、药力薄的小方治疗。如小病用大方，则是杀鸡用牛刀，不仅浪费药物，且又损伤正气。

3.缓方

病程较长，进展缓慢的叫缓病。这类疾患的好转和根治需要一个相当长的过程，当采用缓治之法，“缓方以徐徐见效”，使病情稳步好转，疗效巩固，且不致产生副作用，这就叫作缓病用缓方。若急于求成，缓病而用急方，势必如揠苗助长，不但不能取效，反而带来严重后果。

4.急方

病起仓促，来势凶猛，若不急救，就要发生意外的叫急病。急病用急方。在处理这些疾病时，不仅要行动快，药物齐备，而且要立即给药，马上见效。运用急方，关键在于平时有充分的准备，急救药品、针具等一应俱全，如急病而用缓方，势必失去抢救时机。

5.复方

病情复杂，处方要各方面都照顾到的，叫作复方。临床运用复方的范围很广，不仅药味较多，有的也要寒热并用，攻补兼施，尽可能面面俱到。但分析起来各有所主，它不同于杂方，方虽庞而不杂，药虽多而不乱。

以上所说的五病用五方也不是绝对的。因为大病中还可能有小病，缓病中也可能有急病，而复杂的病情，也要针对其主要矛盾优先解决。所以还必须结合标本缓急等问题，根据具体的情况做具体的处理。

临证在组方时还应注意，轻剂不是隔靴搔痒，重剂不可猛烈太过，复法大方必须组合有序，不能杂乱无章。独行应当药证合拍。

二、主治方与通治方

1.主治方

徐灵胎在《兰台轨范》中明确指出：“一病必有一方，专治者名曰主方。而一病又有几种，每种亦各有主方。”他还认为，如对“一病之主方主药茫然不晓”，治病方药必将“浮泛不经”。这段话与实际情况很为合拍。主治方就是通过对相应疾病的辨证论治，再结合方药理论而制定出来的，有较强针对性的处方，它往往能间接反映出疾病的主要病理变化规律。如泄泻一病，其发生每与湿邪密切相关，可因湿困脾阳而发病，也可随湿被蠲除而获愈。所以运脾化湿、通阳利水的胃苓汤就在《时方妙用》中被称为治泄泻的主方之一。但就主治方本身来说，则是相对的，可因疾病不同的证候表现，不同医家，有较大出入。

一般而言，主治方过多，就会流于烦琐，不易分清主次，难于掌握；主治方少，则简括明了，但有时却粗略偏执，甚至会不敷应用。如《医宗金鉴》治疝气，提到的方剂就有当归温疝汤、乌桂汤、乌头栀子汤、三层茴香丸、十味苍柏散、茴楝五苓散、大黄皂刺汤、羊肉汤、夺命汤、青木香丸、茴香楝实丸等11首之多，而《医学心悟》则仅列橘核丸一张主方，并明言：“治疝之法非一，而分别不外气血，气则游走不定，血则凝聚不散也。橘核丸加减主之。”可见如何抓住疾病的主要矛盾，选出恰切的主治方，也很有讲究。

2.主治方与辨证论治

临证时借鉴主治方，将会有助于辨证论治的顺利进行。例如仲景《伤寒论》创立了六经证治的辨证论治法则，与此同时，也就确立了六经病证的主方，而这正是重要的治疗手段。如果我们熟悉了这些主治方，再来对伤寒进行辨证论治，就能做到胸有成竹。反之，对主治方的运用，则又必须有辨证论治的思维，两者也不能截然分割。如《医学心悟》提出痹证可以“蠲痹汤加减主之”，似十分简捷，然而接下来又说：“风气胜者，更加秦艽、防风；寒气胜者，加附子；湿气胜

者，加防己、萆薢、薏仁。痛在上者，去独活，加荆芥；痛在下者，加牛膝；间有湿热者……去肉桂，加黄柏。”这时就完全遵照辨证论治行事了。

3.通治方

通治方也叫统治方，有通用、统括的意思，主要是指能同时治疗几种疾病的方子。此即《兰台轨范》所说：“如一方而所治之病甚多者，则为通治之方。”因此，通治方适应范围较广，而使用得也多。就以《兰台轨范》所载97张通治方来说，有不少现在就很常用。但在一定条件下，很多通治方又可被选为某一疾病的主治方，而主治方有时也会转变为通治方。如二陈汤既为多种疾病痰湿证的通治方，又是治疗痰饮、咳嗽、呕吐等疾病的主治方。这里转化的条件是疾病的主要病理情况应基本一致。这种兼有主治方性质的通治方由于使用得多，掌握较易，临证时会感到更重要一些。

4.几点体会

(1) 《张氏医通》说：“医林最繁……故选择方论，如披沙拣金。”而疾病主治方的应用，在一定程度上却可为临证带来方便。具体地说，就是通过掌握主治方来联系疾病，以加强对疾病的认识过程。如《医学心悟》治赤白浊选用了两张处方，一为菟丝子丸，一为萆薢分清饮。这是因为作者将此病主要归结为“一由肾虚败精流注，一由湿热渗入膀胱”的缘故。据此，我们就可在他的经验范围内，较顺利地获取应有的疗效。

(2) 对疾病主治方和通治方，既应重点掌握，又不可偏执，更应避免乱套。必须认真总结实践经验，才能不断提高运用方剂的水平。

(3) 各种医籍所确定的疾病主治方，是不尽相同的。这既反映了各医家立方用药各有专长，又体现了临床经验的差异，值得认真研究。实践证明，大部分疾病主治方均有配伍严谨、疗效显著的特点。这在现代通过实验已部分得到了证实。如《医宗金鉴》治妇科“阴

挺”，选用补中益气汤。现经研究表明，此方对子宫周围组织确有选择性兴奋作用。又如《时方妙用》治“上消”，推荐用白虎加人参汤，现也为动物实验所证实，对四氧嘧啶小白鼠实验性糖尿病有效。

（4）现有的疾病主治方，都是在实践中被不断地摸索出来的。我们一方面对前人的经验要很好地学习继承，另一方面更应该通过实践，不断创新，这里面有的可以是旧方新用，有的则是制出新方。如近年来，由于中西医结合研究的广泛开展，出现了不少对西医诊断相应疾病的主治方，如二仙汤、阑尾清化汤、胆道排石汤等。

5.类方比观

类方，一指在同一治法下的同类处方，功用类同，而又同中有异，或因改动药量后，而所治病证有变，若能加以对比择用，更能切合病情，增强疗效；一指以某方为基础，在主治一致的前提下，加以增减衍化，以适应具体病证，体现用方的灵活性。

如寒下剂的承气类方，大承气汤用生大黄攻积破坚，重用枳实、厚朴以行气除痞满，芒硝同大黄后下以软坚润燥，用于痞、满、燥、实、坚俱见者；小承气汤不用芒硝，枳实、厚朴用量亦轻，厚朴用量为大黄之半，用于痞、满、实之证，而燥坚不显者；调胃承气汤不用枳实、厚朴，而大黄与甘草并用以缓其势，后纳芒硝，且少少温服之，用于燥、实为主而无痞满症者。三方峻下、轻下、缓下，各有不同。

三、按方随症加减

由于病情千变万化，有的是病同而证异，有的是证同而病异，所以要选用完全符合病情的现成处方，是少有可能的。用方关键是能够符合主要病机，其差异之处，必须通过随症加减才能解决。《伤寒论》一书中，有许多方剂的后面，详细记载了随症加减，特别是小青龙汤、小柴胡汤、四逆散等方后记载得尤为详细。

怎样随症加减？

(1) 减去方中不符合现在病情之药：如痰湿壅盛，舌苔浊腻的，用二陈汤时要去甘草；感冒风寒夹湿，身体不虚者，用人参败毒散时应去人参等。

(2) 加入对症之药。在针对主症用药的基础上，若同时出现某些兼症，就要适当加入对症的药物以治疗：如伴伤食者加山楂、神曲；伴口渴者加芦根、天花粉；咳嗽有痰者加半夏、陈皮。

(3) 加入对辨病有效的药物：如急性菌痢初起，于芍药汤中加入马齿苋等以控制肠道感染；肺结核活动期，低热盗汗较著者，于百合固金汤中加入百部、葶草、白毛夏枯草等抗痨药。

同时还要注意删繁就简的问题。也就是说处方用药一定要强调少而精，关注方中的主药。对药味较多的方子，要搞清其中必不可少的药物有哪些，便于在精简时心中有数。例如：小青龙汤共八味，其中麻黄、干姜、细辛、五味子为主要药物。普济消毒饮，药共十四味，其中板蓝根、黄芩、元参、牛蒡子、僵蚕为主要药物。其余药物，可以根据具体情况删减，一般把药味精简到十味左右为宜。

第六章 临证选药

清初医学家喻嘉言说：“先议病，后议药。”说明应先正确辨证求因，才能考虑怎样用药。现从临证实践出发，按病机而立法，依法而选方，按方而用药，分以下几个方面来说。

一、熟悉常用治法和处方的代表药

首先必须熟练掌握常用治法的代表药，打好基本功，这样才可在立法的原则下用药。如属按方选药，还应掌握方中主要药物的组成，才能把药选在点子上。如桂枝汤中的桂枝与白芍，白虎汤中的石膏与知母，小柴胡汤中的柴胡、黄芩，大柴胡汤中的柴胡、黄芩、大黄，都是该方的主药。当确定选用某一方剂时，处方中必须有其主药的存在。

二、掌握脏腑用药

按照药物“归经”理论，针对脏腑病位选药。元代名医张洁古根据这种用药法编成“脏腑用药式”，对后世医家有一定的影响。但必须注意，一药未必仅归一经，功用主治亦非一端，且可随配伍而变异，因此切忌机械理解。兹举例如下：

1. 心

益心气：太子参、人参、茯苓、甘草。

温心阳：肉桂、附子、干姜。

补心阴（血）：当归、白芍、麦冬、玉竹。

安心神：枣仁、柏子仁、五味子、琥珀。

清心热（火）：黄连、连翘、竹叶、莲子心。

开心窍：菖蒲、郁金、远志、麝香。

通心脉：丹参、川芎、红花、桃仁、三七。

2.肝

补肝血：当归、杞子、首乌、鸡血藤。

养肝阴：生地黄、女贞子、山萸肉、龟板。

理肝气：香附、青皮、川楝子、白蒺藜。

清肝热：桑叶、菊花、夏枯草、龙胆草、决明子。

温肝寒：吴茱萸、小茴香、橘核、官桂。

平肝潜阳：钩藤、天麻、珍珠母、赭石、牡蛎。

3.脾

补脾气：黄芪、党参、白术、山药、甘草。

温脾阳：干姜、益智仁、砂仁、肉果。

理中气：木香、佛手、陈皮、厚朴。

化脾湿：藿香、佩兰、苍术、厚朴、草果、蔻仁。

升中气：升麻、柴胡、葛根。

养脾阴：天花粉、麦冬。

养胃阴：花粉、石斛、麦冬、乌梅。

4.肺

补肺气：黄芪、党参、太子参、甘草。

养肺阴：天冬、玉竹、北沙参、百合、阿胶。

清肺热：黄芩、萎皮、桑白皮、银花、鱼腥草。

温肺寒：麻黄、细辛、紫菀、款冬花。

肃肺化痰：前胡、杏仁、百部、橘红。

敛肺定喘：五味子、白果、诃子、罂粟壳。

5. 肾

滋肾阴：熟地黄、山萸肉、女贞子、首乌、龟板。

温肾阳：附子、鹿茸、仙茅、淫羊藿、巴戟天。

壮筋骨：杜仲、续断、狗脊、怀牛膝。

利肾水：赤苓、猪苓、泽泻、车前子、防己、滑石。

三、注意随症用药

“头痛用川芎，腰痛用杜仲。”这是批评医家不辨证而“头痛医头，脚痛医脚”的错误做法。但是，随症用药是在辨证基础上的变通处理，仍然具有辨证用药的含义在内。试举几则随症用药的例子于后。

1. 头痛

偏寒：吴茱萸、川芎。

偏热：菊花、桑叶。

偏后脑：羌活、麻黄。

偏前额：白芷、葛根。

偏两侧：蔓荆子、白芍、白蒺藜。

偏巅顶：藁本、吴茱萸、牛膝。

顽固性头痛：白附子、僵蚕、全蝎。

2.咳嗽

风寒：麻黄、苏叶、杏仁。

风热：桑叶、菊花、桔梗。

湿痰：姜半夏、陈皮、厚朴。

阴虚：百合、麦冬、川贝。

痰饮：干姜、细辛、五味子。

肺痛：芦根、鱼腥草、桔梗。

久咳：百部、诃子。

3.胃脘痛

寒痛：高良姜、吴茱萸、乌药。

热痛：黄连、川楝子。

虚痛：黄芪、党参、白术、白芍。

气痛：沉香、砂仁、枳壳、香附。

瘀痛：延胡索、五灵脂、三七。

食痛：麦芽、谷芽、神曲。

虫痛：使君子、槟榔、乌梅。

4.低热（虚热）

虚热有汗：秦艽、地骨皮、知母。

虚热无汗：丹皮、青蒿、地骨皮。

掌心热：丹皮、山栀。

掌心灼热多汗：鳖甲、地骨皮、乌梅。

潮热骨蒸：银柴胡、白薇、胡黄连。

四、结合辨病用药

所谓辨病用药，一般是指区别于辨证论治而按病用药，含中医的病及西医的病，如治肝炎方药、治气管炎的经验方药等。也包括按现代药理来使用中药的，如降转氨酶药、降血压药、降血糖药等。若单求辨病用药，是不妥当的，但是在辨证施治的基础上结合辨病用药，可以弥补辨证用药之不足。如用枳壳结合补中益气汤治疗胃下垂，用三金汤（鸡内金、海金沙、金钱草）结合辨证用药治疗胆结石和尿路结石等。

五、根据经验用药

所谓经验用药，是指中医在长期临床实践中，具有独特经验之用药。例如：大黄本为通便药，与甘草同用则能利小便；用少量麻黄配伍大量熟地黄则能治下虚上盛之喘，开肺气而麻黄不汗，补肾元而熟地黄不滞；茯苓得白术则补脾；牛膝能引血下行，亦能引其他药下行，故又称本药为“下部之使药”，但也能因其性下行而引发遗精。

六、拓宽中药新用途

中药的基本特点是多组分的混（复）合物，且其主要成分未必就是唯一的有效成分，但由于中药具有多种组分，因而其功效也是多向性的。前人通过实践的积累，虽已认识到每味药的主要功效，但尚有未被发现的效用，须在临床应用中探索，结合现代药理研究手段和方法，寻求新的药效。兹举例如下：

漏芦苦寒，主用于乳病及疮肿毒，可治产后乳汁不下，长于通络活血、解毒消痈。笔者据此先后应用于骨巨细胞瘤、乳腺癌等多种肿瘤有热毒征象者，具有良好的解毒抗癌、散结消肿作用。鬼箭羽苦寒，功能破血通经、散瘀止痛，习用于闭经、产后瘀滞腹痛及风湿痛等症，笔者据此试用于癫狂、类风湿关节炎、慢性肾炎、狼疮、糖尿病等具有血瘀特征者，颇能增效。泽漆苦、微寒，有小毒，功能泻肺化痰、止咳降气、利水消肿，现代多用于慢支咳喘、肺结核等病，笔者据其化痰利水、散结解毒之功，用于慢性咽炎、心源性咳喘、水肿、肿瘤等，确有良效。天仙藤味苦性温，行气活血，通络利水，《妇人良方》载有天仙藤散治子肿，笔者据此扩大应用于功能性水肿、特发性水肿，并配鸡血藤治疗高血压病的气血失调证，颇有效验。金毛狗脊辛苦温，功能祛风湿、利关节、补肝肾、壮筋骨，习用于风湿痹痛、腰脊酸痛、腿膝软弱，对肾虚不固的尿频、带下清稀者，有固涩作用。

七、注意药物的主次排列

用药离不开君臣佐使的原则，在处方时应当注意到君药、臣药居前，佐使药居后，这样做有利于检查自己的处方是否方证吻合。在君臣药排列时，应紧紧扣住立法与选方。如选用桂枝汤，应桂枝、白芍居前；选用麻黄汤，应麻黄、桂枝居前；选用五苓散，猪苓、茯苓、泽泻居前。若依法处方者，则以仅对立法之药居首，如因于痰，以湿痰为主者，半夏、陈皮居前；风痰为主者，白僵蚕、胆南星居前；燥痰为主者，瓜蒌、贝母居前。有人说甘草调和诸药，列为使药居后，其实也不尽然，如脾气虚弱选用四君子汤，甘草为使，应书于处方之末；若为心气虚悸选用炙甘草汤时，则甘草是主药，自应列在首位。

八、引经与反佐

引经药，古称引经报使药，中医认为某经有病当用归某经的药物作向导，如太阳头痛用羌活，阳明头痛用葛根等。目前称为药引的，约有两种：其一，确能引导诸药在某部位发挥较大作用者，如上部病

用桔梗、下部病用牛膝之类。其二，属于习惯的自加中草药，如生姜三片、大枣二枚等。把这些药写在方末，便于自加，并非皆有引经作用。

关于反佐，这是用相反药佐正治而成效，如胃热呕吐，投苦寒而格拒者，可用姜汁炒黄连。姜汁性温，用于热证，就是反佐。这样可以提高治疗效果，减少副作用。

九、中药的用量与炮制

处方中药物的用量及炮制，既直接影响疗效，又涉及用药安全性。这里主要谈在实践运用中的几个具体问题。

1.关于用量

中药多为天然药材，其用量较大，有效量的安全范围也较宽。但也不是绝对的，有些剧毒药物如乌头、巴豆之类稍稍过量，就易发生中毒。总的来说，加大用量，并不与提高疗效成正比，如何权衡中药之用量，可从下面四个方面着手。

(1) 严格控制剧毒药用量：如川乌头，有效量为3~6克，煎服如超过10克，就易发生中毒，如超过30克，就易发生死亡事故，必须严格掌握。若延长煎煮时间，可以减低其毒性。

(2) 按药物作用的地位而定量：一般地说，君药、臣药用量偏重，佐药、使药偏轻。例如用桂枝汤时，桂枝为主，白芍为辅，桂枝用5克，白芍用10克；用小建中汤时，白芍为主，桂枝为辅，桂枝用3~4克，白芍用15~20克。且桂枝、白芍用量都超过常用量。再如治阳虚寒证病人，一般用四逆汤，附子为主（5~8克），干姜为辅（2~5克）。若病情严重，阳脱脉伏者，当用通脉四逆汤，干姜为主（8~10克），附子为辅（4~6克），余可类推。

(3) 根据不同作用要求掌握用量：如柴胡作为和解退热的用量宜偏大（12~15克），作为疏肝解郁药宜偏轻（3~6克）。又如防

风，作为疏风发表药，可用一般量（5～10克），解砒霜毒时当用大量（30～45克）。

（4）注意药物的体积掌握用量：同一剂量的药材，体积差距很大。如磁石10克，只有三粒黄豆大小；若10克玉蝴蝶或通草，可占半药罐。为了符合煎煮的要求，应掌握用量，适当考虑到药材的体积。如矿石、贝壳类药物，用量可偏大些，一般在30克左右。对有些体积虽大而用量又不能小者，可采用煎汤代水煎药方法。如伏龙肝、夏枯草、葫芦瓢、益母草等药用大剂量时，就要先将药物煎汤去渣取水再煎他药。

2.关于炮制

中药炮制直接关系到临床疗效，在这里主要谈谈有关的几个具体问题。

（1）重视必要的炮制：为了减少毒性，提高疗效，必要的炮制是不可少的。如生半夏用生姜同煮，制成姜半夏，可以减少半夏的毒性；陈棕炭、血余炭等用于止血，必须烧炭存性，否则就不易于煎煮和消化吸收。炒黄芩善于退热，焦薏苡仁健脾止泻，在书写处方时都必须注明。

（2）避免有害的炮制：过去有些炮制，为了追求美观，反而失去药效。如清水半夏片、花槟榔片、淡附片等，要把药物用水浸多天，把味浸淡，切出的饮片犹如爪甲，光泽透明，非常好看，实际上有效成分大部分都已失去。

（3）改革烦琐的炮制：如蚌水炒天麻，很难肯定被炒的药味有什么新的特殊作用。

（4）必要的医嘱：这里所讲的“医嘱”，主要是指有关服药要求的嘱咐。

1) 服药次数：急性病服汤药要大量频进，必要时每4～6小时一次；频繁呕吐，饮食难进者，应采用少量多次分服法。若为慢性疾患，服药每天1剂，或两天1剂。

2) 服药时间：一般每日服两次者，早晚服用为宜。夏令服药，最好头一天晚上服“头煎”，第二天早上服“二煎”，这样可避免中午高温时间汤药发馊。对胃部有刺激性的药物，如补血丸中有皂矾等药，以饭后服药较好。病在上焦者饭后服，在下焦者饭前服。如服发表药，服后宜温覆以取汗，避免当风受凉。有些病在服药时应嘱咐注意病情变化，如服泻下剂，必须遵守“得利止后服”的原则，不使过剂伤正。另外尚需交代所服药物的有关饮食宜忌等问题。

第七章 常用药物的配伍

中药的配伍合用是从单味药发展而来的，也是组成方剂的基础，配伍得当可以加强作用，提高疗效，适应复杂的病情。

一、同类相须

同类相须是指将两味功用相近的药物配伍合用，习称为“姐妹药”，如金银花与连翘、三棱与莪术、乳香与没药、荆芥与防风、桃仁与红花等。临床运用要注意“姐妹药”并不是所有的作用皆相同，如桃仁与红花，在活血化瘀方面是“姐妹药”，但若用于大便燥结，红花不能代桃仁，用于关节痹痛，桃仁不能代红花。荆芥与防风，在发散风寒方面是“姐妹药”，若遇产后血崩，需用荆芥炭者，防风不能代替。同类相须配伍，既需与病证相符，还要区别各自特性，把握同中有异的作用。

1.麻黄、桂枝

麻黄辛温发汗，通阳散寒，祛营中寒邪；桂枝辛温解肌，祛卫分风邪，行阳活血，为血中气药，能引血中之寒外达。二者相须相使，增强散寒发汗、温经宣痹作用。用于风寒感冒、痹痛、水肿。

2.荆芥、防风

荆芥、防风辛温解表，祛风散寒，协同增效。适用于外感风寒表证，恶寒发热，无汗，头痛，身痛，并可祛肌表之风，而治皮肤痒疹。

3.麻黄、细辛

麻黄发汗解表，宣肺平喘，细辛散寒止痛，温肺化饮，多用于寒邪犯表，痰饮阻肺，恶寒身热，无汗身痛，喘哮咳逆，痰多清稀者。

4.川芎、白芷

川芎上行头目，为祛风活血止痛要药；白芷祛风止痛，引川芎而入阳明，治偏正头痛，反复久延不愈。

5.天麻、川芎

天麻入肝息风，缓肝而治肝虚风动之眩晕，川芎入血行气，血行则风息而头痛平，二者共奏平息肝风、定眩止痛之功，主治肝风上扰所致的眩晕头痛、肢体麻木等症。

6.苏叶、香附

苏叶散寒解表，香附理气疏郁，主治风寒夹气滞，无汗恶寒，周身胀痛，胸脘痞闷，且能顺气安胎，治疗妊娠呕吐。

7.金银花、连翘

金银花、连翘清热解毒，协同增效，治风温病，表里俱热，且可凉血解毒，治疗痈疮。

8.黄芩、桑白皮

黄芩泻肺中实火，桑白皮泻肺中郁热，可佐黄芩清肺，二者配伍，泻肺、平喘、止咳，用于肺热壅盛，气逆咳喘，咳痰黄稠。

9.桑叶、菊花

桑叶、菊花疏风散热，轻宣肺气，相须增效，用于外感风热或温病初起，发热，头痛，咳嗽，咽痛。

10.栀子、丹皮（桑叶、丹皮）

栀子苦泻清肝，丹皮凉血泄热。为泻肝清火常用药物。桑叶清肝经气分之热，轻清疏泄，上走头目，配丹皮气血两清。

11.丹皮、大黄

丹皮入血，清热凉血，活血散瘀；大黄苦寒通下，清热解毒，凉血消瘀。两者合用，更能泻热散瘀，荡涤热毒瘀滞，常用于肠痈、附件炎、盆腔炎等。

12.青蒿、黄芩

青蒿清透少阳邪热，黄芩苦泄肝胆湿火，二者相伍，共奏和解清泄之功，治疗热郁少阳，外受暑湿，寒热往来，热重寒轻，胁胀口苦等症。

13.夏枯草、蒲公英

夏枯草善清肝火，疏通郁滞，散结消肿；蒲公英清热解毒，消痈散结。二者合用，清火解毒更强，可用于肝经实火、热毒内蕴所致的咽喉肿痛，目赤肿胀，疔疮痈肿，如肝炎、乳痈、淋巴结肿等。

14.胡黄连、银柴胡

胡黄连入血，清阴分伏热，银柴胡凉血，清肝胆虚热，二药合用，可治内伤劳热骨蒸，午后潮热，夜热早凉，手足心热，盗汗，小儿疳热等症。

15.桑白皮、地骨皮

桑白皮、地骨皮二者皆可入肺清热，润而不燥。桑白皮偏入气分，泻肺中邪热；地骨皮能入血分，清肺中伏火。二者相伍，治肺热阴伤，喘咳气逆。

16.栀子、黄柏

栀子清肝经之郁火，黄柏泻脾之湿热，二者相伍，能增强清热利湿之功，治疗阳黄热重于湿，尿赤，下焦热淋等症。

17.生地黄、大黄

生地黄凉血清热，滋阴生津；大黄泻下热结，降火凉血。二者合用，可增强清热凉血止血之功，治疗心胃火炽，阴伤火炎之出血。

18.大黄、黄连

大黄、黄连苦泄胃热，泻火止血，主治胃火内燔，迫血妄行，以及肺胃热盛，吐血、咯血、口舌生疮等症。

19.青蒿、白薇

青蒿、白薇清透气营伏热，治温病后期，高热已退，低热不清，午后为甚，热郁气营，或内伤劳热。兼有阴伤者，配鳖甲、地骨皮。

20.全瓜蒌、薤白

全瓜蒌、薤白豁痰散结，通阳宣痹，治疗胸痹证，临床以胸闷胸痛、舌苔浊腻为主症，如胃炎、肺气肿、冠心病具有以上特点者均可应用。

21.石膏、知母

石膏辛寒透热，知母苦寒降火，二者合用，清胃除烦，治胃火内盛，阳明气分实热，见壮热、汗多、烦渴、面赤、脉大者。

22.黄连、黄芩

黄连泻心胃之火，黄芩清肺胃之热，二者相伍，治上、中二焦火热炽盛所致的身热，头面红肿焮痛，口舌生疮，烦躁不寐，吐衄发斑，神识昏迷等症。

23.知母、黄柏

知母、黄柏清利下焦湿热，治热淋，尿频急疼痛。配肉桂化气行水，治湿热癃闭；肾阴不足、水亏火旺，配生地黄、龟板滋阴降火。

24.人参、蛤蚧

人参、蛤蚧补肺益肾，纳气平喘，治肺肾两虚，咳嗽气喘，动则为甚，汗多，语言无力。

25.白僵蚕、白芷

白僵蚕、白芷祛风通络，走阳明而治风热头痛、齿痛，可随寒热主次配药，亦治湿浊下注，妇女白带。白僵蚕、白芷各10克，配伍生川草乌各1.5克，生甘草10克，研成粉剂，分成9包，每日3次，每次1包，用绿茶送下，有祛风散寒通窍之功，治风寒头痛、偏头痛。

26.天麻、豨莶草

天麻、豨莶草平肝息风，主治肝风眩晕，手指麻木，以及血管硬化、血压偏高等。伴见头皮、手足麻木者，重用豨莶草；伴见头昏晕痛、目花者，重用天麻。

27.白僵蚕、地龙

白僵蚕、地龙搜风化痰通络，治风痰入络，头痛，三叉神经痛，口眼歪斜，肌肉跳动等。

28.苍术、厚朴

苍术苦温性燥，除湿健脾，升运脾气；厚朴苦温性散，化湿除满，和降胃气。二者配伍，共奏化湿运脾、行气和胃之功，治湿困中焦，胸膈痞塞，脘腹胀满，呕恶不食，口黏，舌苔厚腻等。

29.高良姜、香附

高良姜温胃散寒，理气和中，香附疏肝解郁，理气止痛，二者合用，可治寒凝气滞，胸闷胁痛，喜温喜按，口淡多涎，苔白等症。

30.附子、干姜

附子辛热，走而不守，回阳补火，散寒除湿；干姜辛温，守而不走，温中回阳通脉。二者协同增效，可回阳救逆，祛寒破阴。

31.当归、白芍（当归、川芎）

当归、白芍（当归、川芎），养血和血，以养为主，治疗肝病、胁痛、风痹、月经不调等病。川芎、当归并用名佛手散，可治妊娠伤胎难产，胞衣不下。

32.肉苁蓉、当归

肉苁蓉、当归润肠通便，主治虚人、老人肠燥津枯便秘。

33.三棱、莪术

三棱长于破血中之气，莪术善于破气中之血，二者合用，破瘀散结更强，治疗气滞血瘀所致的癥瘕积聚，心腹诸痛，腹部肿块，妇女经闭经痛。

34.穿山甲、王不留行

穿山甲性走窜，可活血通络，宣通脏腑，力达全身；王不留行入血通脉，逐瘀开闭。二者合用，祛瘀通络之功更强，治疗气血瘀滞所致之癥瘕积聚、痈肿、妇人经闭、痛经、产后乳汁不下。

35.补骨脂、胡桃肉

补骨脂温肾暖脾，壮阳止泻，纳气平喘；胡桃肉养血益气，补肾填精、敛气定喘。两者合用，刚柔相济，功能补肾壮阳，纳气平喘，强健筋骨，主治肺肾两亏之虚喘、阳痿早泄、腰膝酸软。

36.垂盆草、龙胆草

垂盆草清肝降酶，甘淡渗泄，清不伤正，苦不损肝。龙胆草苦寒泻火，清热燥湿。二药合用，可增强降酶作用。湿热盛者加苦参。

二、异类相使

异类相使主要是指将两味以上功用不同的药物合用以提高疗效，但也涵盖相杀及相畏、相恶等药物的配伍，以使其增效减毒。临证还应当根据复法治疗的需要，把握药物的配伍关系，才能取得预期疗效。兹举例介绍相关配伍如下：

1.补阴与补阳

要注意把补阴与补阳结合起来，或以补阳为主，结合补阴，或以补阴为主，结合补阳，适用于阴阳两虚。

熟地黄、附子：熟地黄补肾阴，附子补肾阳，二者合用，可水中补火，以治肾虚。

龟板、鹿角：龟板补任脉之阴，鹿角补督脉之阳，二者合用，阴阳并补，填补精血（如龟鹿二仙胶）。

2.补气与补血

血为气母，气能生血，“有形之血不能自生，生于无形之气。”

黄芪、当归：黄芪益气生血，当归入血（为引）补血，二者合用，可益气生血，治血虚形痿。

当归、人参：当归补血，人参益气，二者合用，补阴中之阳，血中之气，治气虚。

3.补与消

白术、枳壳：白术补脾健脾，枳壳破气开痞，二者合用，消补兼施（补破兼施），治脾虚气滞，食积成痞。

枳实、白术：消补兼施，补脾消痞，用于心下痞胀，脾虚夹有积滞等。白术得枳实补而不滞，枳实配白术攻而不伤。若气虚加党参、橘皮；湿壅合平胃散；气滞配木香、砂仁。

熟地黄、砂仁：熟地黄补肾阴，砂仁健脾胃，二者拌蒸后合用，治肾虚脾弱，能减少地黄滋腻碍胃之弊。

肉苁蓉、沉香：肉苁蓉补肾润肠，沉香理气调腑，二者合用，治老年虚秘。

4.补与散

黄芪、防风：黄芪补气固表，防风祛风散寒，二者合用，治表虚自汗，易感冒。防风升散阳气，引黄芪达表。

人参、苏叶：人参补气，苏叶发散风寒，二者合用，扶正祛邪，治气虚卫弱、风寒表证。

枸杞子、菊花：枸杞子补肝肾阴，菊花清散风热，二者合用，治肝虚、目疾、眩晕。

5.补与泻

熟地黄、泽泻：熟地黄滋肾阴，泽泻泻肾经湿热，二者合用，治肾阴虚而有湿热。

黄芪、防己：黄芪益气，防己利水湿。二者合用，治风水浮肿，表虚身重、汗出、恶风。对慢性肾炎、心源性水肿有效。

6.补与攻

甘遂、大枣：甘遂逐水，大枣护胃气、解毒，二者合用，治悬饮、胸水。

大黄、当归：大黄泻下通腑，当归润燥补血，二者合用，润下通幽，治阴血亏耗，燥热内结。

大黄、人参：大黄通腑，人参补气，二者合用，扶正祛邪，治正气虚弱、燥热内结之证。

7.行气与活血

川楝子、延胡索：川楝子理气，延胡索活血，二者合用，治气结血瘀刺痛。

香附、当归：香附理气解郁，当归和营活血，二者合用，治气血郁结之痛。

8.升与降

桔梗、枳壳：桔梗化痰宣肺，枳壳下气利膈，二者合用，治痰气郁结，胸膈痹闷，脘部痞满。

柴胡、前胡：解热宣肺，一升一降。柴胡主升，功在解热散邪，前胡主降，功在宣肺止咳，下气化痰，二者合用，治时邪发热，咳嗽胸闷，肺气不利。若寒热往来较著，重用柴胡；若咳逆胸闷较著，重用前胡。

川芎、大黄：川芎引药上行，大黄清热泻火，二者合用，清上部湿热火毒，治疮疡、目赤、头眩、头痛。

9.散与敛

细辛、五味子：细辛散寒解表，五味子收敛肺气，二者合用，治寒饮蕴肺，肺虚上气咳逆。

桂枝、白芍：桂枝发汗解肌，白芍敛阴和营，常加入甘草同用，属辛甘、酸甘复法，具有和阳化阴、调和营卫作用。用于感冒（太阳

中风)、胃痛、腹痛、痹痛、自汗等症。在杂病调理补养方中常用。气虚加黄芪，血虚加当归，中虚加饴糖。

10.表与里

麻黄、石膏：麻黄宣肺散寒，石膏清肺泄热，二者合用，治表寒里热、邪热郁肺、风温喘咳、风水证。

麻黄、黄芩：麻黄辛散，宣通肺气，黄芩苦寒，清肺降火，二者合用，治表寒肺热、痰热壅肺之咳喘。

柴胡、黄芩：柴胡透达半表之邪，黄芩清泄半里之热，二者合用，入少阳肝胆，和解枢机，疏散郁热，治寒热往来，胸胁苦满，心烦欲呕，口苦咽干等症。

桂枝、石膏：桂枝祛卫表之寒，石膏清内伏郁热，二者合用治外寒束表，背微恶寒，内热烦躁，热痹证，关节痛，身痛。

淡豆豉、栀子：淡豆豉解表疏风清热，栀子清热除烦，二者合用，解表清里，治热郁气分，发热，胸膈烦闷。

麻黄、附子：麻黄发表散寒，附子温里，二者合用，温经散寒，治风湿相搏，身体疼烦。

薄荷、石斛：薄荷解表发汗，石斛滋阴生津，二者合用。养阴发汗，用于肺胃津液不足，外有表证，不能得汗者。

淡豆豉、生地黄：淡豆豉发表，生地黄滋阴，二者合用，治素体阴亏，温邪失表，不能得汗，邪从气分入营，发热无汗，烦躁，舌质红。

11.寒与热（温与清）

细辛、石膏：细辛升散郁火，石膏清阳明胃热，二者合用，治阳明火热上攻，头痛齿痛。

细辛、黄连：细辛升散郁火，黄连清心泻火（如属肾火改黄柏），二者合用，治心肾火炎、口舌生疮。

大黄、附子：大黄通腑下积，附子温中祛寒，二者合用，治寒积便秘腹痛。亦用于噎膈、食道痉挛、尿毒症以呕吐为主症者。

大黄、肉桂：大黄清热通腑，肉桂温里化湿，二者合用，治痢疾迁延，湿不化，热不清，腹痛，下利脓血。亦可治血证。

木香、黄连：木香行气消滞，黄连清湿热，二者合用，治湿热痢疾。

苍术、黄柏：苍术燥湿，黄柏清热，二者合用，治湿热在下焦，腿膝肿痛，小便赤涩、短少、疼痛。

肉桂、黄柏：肉桂助阳化气，黄柏清湿热，二者合用，治湿热蕴结膀胱，小便不利，咽痛。

黄连、肉桂：黄连清心火，肉桂引火下行，二者合用，交通心肾，治失眠、口腔糜破、心烦、肢冷等症。

苍术、石膏：苍术燥湿，石膏清热，二者合用，治湿温发热，肢体酸重疼痛。

白芷、黄芩：白芷祛风，引黄芩上行以清头目，黄芩清肺热，制白芷辛温香燥之性，二者合用，治风热之头额眉棱骨痛。如阳明有热，用石膏代黄芩。

12.开与泄

即辛开苦泄法，治胃气不降出现痞满、疼痛、呕吐等症。

黄芩、厚朴：黄芩清胃肠热，厚朴燥脾胃湿。二者合用，化脾胃湿热，治湿温之湿遏热伏，身热不退。

黄连、附子：黄连清胃泄热，附子温中止痛，二者合用，寒热杂投，治胃痛脘痞。

黄连、半夏：黄连清热，半夏化痰，辛苦合用，化痰热，开痞结，可治呕吐。

黄连、吴茱萸（连苏、连朴、连姜）：苦降辛开，有开郁散火、泄肝和胃、止吐制酸作用，用于肝火郁结所致胃痛、嘈杂、吐酸见苔

黄、口苦、脉弦数等症者。腹痛加白芍（戊己丸）。如脘痞，噫气呕吐，用黄连、苏叶；湿热阻于中焦，脘胀、苔黄厚，用黄连、川朴；寒热错杂用黄连、干姜。

总之，中药配伍不仅是单纯有效量的积累，同时还可产生质的变化（如乌梅甘草同用，有酸甘化阴、敛肝和胃的作用），能影响、甚至改变其作用，提高疗效，更好地发挥其在某一方面的专长而减少其副作用与毒性（如半夏配生姜），或牵制其偏性，此即古人所谓“使药各全其性、各失其性”的意思。也就是说，药物的功效不止一个方面，不同的配伍，可以发挥不同的特长，并避免其偏弊，有时甚至药量的比例不同，在作用上也都可发生变化。因此，必须根据疾病的特点、证候的本质和矛盾主次关系，确定药物的配伍，正确掌握和利用药与药之间的不同特性及互相联系、互相制约的关系，将中药配伍列为辨证论治的重要一环，用对立统一的辩证法思想，理解、应用、总结药物的配伍规律。

第八章 常用脏腑病机词汇类证辨治

一、病机的含义

病机是指疾病的病因、病位、病性及病程中变化的要理。病机词汇则是指说明疾病病变机理的一些专用名词，亦可称为病机术语，它是构建临床辨证诊断的基础。

二、病机的掌握

必须审证求因，运用四诊，收集症状、体征，通过分析归纳，推断病因、病位、病性及其发展转归，辨别证候属性，从而认清病变机理。

三、病机词汇在临床上的重要意义

首先，病机词汇能高度概括辨证所得印象。

其次，病机词汇是指导实践的理论依据。

第三，病机词汇是推断疾病证候表现的基础。

第四，病机词汇能反映病变的整体关系及其发展转归。

四、本节讨论范围

拟在脏腑辨证理论的基础上，选择一些临床常用病机词汇中的类似证候，加以对比鉴别，并适当联系治法和方药，以求在临证时能比

较确切地掌握和运用病机词汇，书写病历，表达辨证所得印象，使其为实践服务。

五、常用病机词汇选释

1.心气虚弱与心阳不振

心阳不振包括心气虚弱。因阳虚必然兼有气虚，气虚可以发展到阳虚。也就是说在心气虚的基础上，表现有阳虚证象的，则为心阳虚。区别言之，两者病情有轻重之别，病势有缓急之分。

气虚病轻而势缓，主症为心慌，气短，胸部憋闷，劳累活动后明显，自汗，神疲，喜卧，脉虚大、濡弱、结代，舌质淡胖，苔白。

阳虚病重而势急，兼有汗出肢冷，面浮肢肿，面色灰暗青紫，舌质淡润、紫蓝，脉沉迟等虚寒表现。如发展到阳气虚脱，可见大汗淋漓，四肢厥冷，咳喘气逆，烦躁，神识昏糊，脉微细欲绝，或模糊不清。

治法：气虚的，补益心气，用养心汤。阳虚的，回阳救逆，用四逆加入参汤、参附汤。药如黄芪、党参（人参）、炙甘草及附子、肉桂等。

2.心血瘀阻与心阳痹阻

两者均属“心痹”范围，以发作性的心胸暴痛为主症。其区别点在于是血瘀，还是阴寒、痰浊。

心血瘀阻者，其痛如绞如刺，牵及肩背，面如漆柴，舌色紫黯，舌有紫斑、紫点，或全部舌质黯紫，脉细涩或结代。

因心阳痹阻所致的胸痛其因有二：一为阴寒偏盛，寒凝气滞，痹阻胸阳。症见猝痛无声，口鼻气冷，手足清冷至节，面色发青，汗大出，昏厥不清，舌质淡蓝或淡紫，脉沉迟伏。一为痰浊壅塞，心阳失

旷。症见胸痛如塞，心胸憋闷，呼吸喘促，咯吐黏痰，舌苔浊腻，脉缓滑。

治疗：心血瘀阻，当活血行瘀。用血府逐瘀汤，药如桃仁、红花、乳香、没药、丹参、莪术、三棱等。若因心阳不振，血行不畅，而致心血瘀阻者，当在温补心阳的基础上，加入活血行瘀药。心阳痹阻，因阴寒偏盛者，当温通阳气，药如干姜、附子、肉桂、甘草等，痛剧可服苏合香丸。因痰浊壅塞者，当通阳泄浊，用瓜蒌薤白半夏汤，药如瓜蒌、薤白、半夏、石菖蒲。

3.肺气不宣与肺失肃清

两者均属邪犯于肺的实证，以咳嗽为主要临床表现，并可见气喘、音哑（金实无声）。主要区别在于病因的属寒属热。

肺气不宣一般习惯指外感。肺失肃清包括外感和内伤，或外感邪恋较久者。亦可表现为肺失宣肃，因平素肺有蕴热，而风寒外束，或风寒犯肺，内郁化热而表寒未解（寒包热）。

肺气不宣，多因寒邪束肺，肺气失于宣畅，症见咳嗽气急，痰吐色白质稀，鼻塞流涕，恶寒发热，汗少，苔白，脉浮紧。

肺失肃清，多因热邪（风热、痰热）犯肺，肺失肃降，症见咳嗽气粗，痰黏或稠黄，或痰中带血，或有身热，口渴，苔黄，脉数。

治疗：肺气不宣，治当宣肺散邪，用三拗汤及桔梗、前胡等。肺失肃清，治当肃清肺气，用桑白皮、黄芩、知母、白前、葶苈子。如宣降俱病，则应宣降并施，用麻杏石甘汤，药如麻黄配石膏、黄芩或葶苈子。

4.燥伤肺津与阴虚肺燥

二者都见肺有燥热，阴津耗伤的表现。区别者在于病因有外感内伤之分，病史有新旧之异。

燥伤肺津是因外感温燥之邪，燥热耗伤津液，病情较轻。阴虚肺燥是在阴虚的基础上，因阴液损伤，产生内燥现象，多见虚候，甚则病及于肾，表现肺肾阴虚（金水交亏）。

燥伤肺津，为风燥犯肺，肺失清润。症见咳呛气逆，痰少而黏，或带血丝，口干、唇鼻干燥，咽喉干痛，咽痒，心烦，或伴鼻塞，微寒身热等表证，多见于秋令，苔薄白或薄黄，舌质干，舌边尖红，脉浮数或细弦数。

阴虚肺燥，为肺阴亏耗，虚热内灼所致。症见干咳，痰少质黏，或夹血丝，声音嘶哑，午后潮热，颧红，盗汗，口干咽燥，形体消瘦，肌肤枯燥，舌质红，舌苔少，脉细数。

治疗：两者一清一滋，各有重点，不可混淆。燥伤肺津，清肺润燥，一般用桑杏汤；燥火内盛，用清燥救肺汤。药如桑叶、花粉、知母、南沙参、杏仁、梨皮、芦根。阴虚肺燥，滋阴润燥，用沙参麦冬汤、百合固金汤。药如北沙参、麦冬、玉竹、鳖甲、地骨皮。肺损络伤，咯痰夹血，加白及、阿胶、橘络；声嘶、语暗（金碎不鸣），加诃子、凤凰衣、胡桃肉、白蜜。

5.脾气虚弱与脾阳不振（中气不足与中阳不振）

两者均属脾虚，而致运化功能不健（脾失健运）。气虚较阳虚为轻，但气虚进一步发展则见阳虚。区别点在于有无寒象。

脾气虚弱，因中气不足，运化无力，清气不能上升，甚则中气下陷，或肺脾同病（脾虚肺弱，土不生金），并见肺气亏虚之证。脾阳不振，为脾胃阳气虚弱，寒从内生，表现虚寒征象，严重者可发展成脾肾阳虚。

脾气虚弱，症见面色萎黄，神疲乏力，食少，纳后脘胀，或有隐痛，便溏不实，舌苔白，舌质偏淡，脉濡缓。如见脾气下陷，则脘腹坠胀，头昏，气短，久泻，脱肛，小便频数淋漓。若脾不统血，可见吐血、便血、紫癜、崩漏。

脾阳不振，症见面色苍白，脘腹冷胀，呕吐清水，喜热喜按，食少运迟，大便下利清谷，四肢清冷，形寒，或有浮肿，舌苔白，舌质

淡胖，脉沉细（弱）。

治疗：脾气虚弱，当补气健脾，用参苓白术散，或补中益气汤。药如党参、黄芪、白术、甘草、山药等。中气下陷，应补而兼升，加升麻、柴胡；脾不统血，应补而兼摄，加白及、炮姜炭、赤石脂。脾阳不振，当温中健脾（温运脚阳），用附子理中汤，药如附子、肉桂、炮姜、白术、人参、茯苓、甘草等。

6.脾胃不和与肝胃不和、肝脾不和

三者都有脾胃运化功能失调的共同表现。区别之处，在于前者表现脾胃症状而无肝病证候，以脾胃运纳失常为主，后二者则都同时有肝病证候，或为肝气犯胃，或为肝气乘脾，亦可同时并见。脾胃不和偏于虚证，肝脾不和虚实相兼，肝胃不和又偏于实。脾胃不和（脾失健运，胃失和降），症见胃部饱闷、发胀、隐痛，食少，纳后运迟，暖气，甚则呕吐，腹胀肠鸣，大便多溏，舌苔薄白，脉细。

肝脾不和与肝胃不和，在肝经病证方面，都可表现胁肋胀痛或窜痛，恼怒则甚，胸闷，头昏，脉弦。肝气犯胃则脘部胀痛，暖气，泛酸，嘈杂，恶心，呕吐；肝气乘脾则腹痛，肠鸣矢气，大便溏薄，久则出现食少、倦怠等脾虚症状。

治疗：脾胃不和，当健脾和胃，用香砂六君子汤（或异功散），药如党参、白术、炙甘草、木香、砂仁、陈皮。肝脾不和，当抑肝扶脾（抑木扶土），用痛泻要方、四逆散，药如柴胡、白芍、枳壳、甘草、白术、陈皮、防风、乌梅、玫瑰花。肝胃不和，当疏（泄）肝和胃，用柴胡疏肝饮，或左金丸，药如柴胡、白芍、枳壳、甘草、香附、青皮、延胡索、川朴花、甘松。

7.肝气郁结与肝气横逆、肝气上逆、肝气入络

一般地说，肝气郁结是基础，在肝失条达、疏泄失常的情况下，可进一步演变出现横逆、上逆、入络等证。区别言之，肝气郁结称肝郁证，肝气横逆等属肝气病，但肝郁有时可以进一步转化为肝气病。

肝气郁结是肝的疏泄功能障碍，如影响脾胃的，为“木不疏土”。肝气横逆，因肝气亢盛，以致犯胃、克脾，乃属“木旺克土”。此外，亦可表现上逆、入络等证。

肝气郁结，指肝气自郁于本经，胁肋胀痛或窜痛，胸闷，喜叹息，情绪抑郁，胁肋疼痛随情绪变化而增减。

肝气横逆，包括犯胃和乘脾两个方面（可联系参阅上条）。

肝气上逆，咽中有异物梗阻感，头痛，眩晕，胸胁苦闷，或噎气，呃逆，呕吐，或咳呛阵作。

肝气入络，为肝气久郁，从气入血，气滞血瘀，络脉痹阻，而致胁肋刺痛，胸背肢体走窜胀痛、麻木，或见腹中癥瘕积聚。

治疗：肝气郁结，当疏肝理气，用柴胡疏肝散，如属血虚肝郁，可用逍遥散养血疏肝，药如柴胡、白芍、炒枳壳、香附、青皮、郁金、炒延胡索、佛手、当归。肝气上逆者，当平肝降逆，用四七汤加旋覆花、赭石、沉香、降香、枳壳。肝气入络，则当在疏肝理气的同时，兼通血络，用旋覆花、当归、红花、泽兰、鸡血藤、天仙藤。

8.肝风内动与肝风上冒、肝风入络

统属肝风证，以肝阳亢盛为基础，因阳化内风，肝风内动，而致上冒颠顶，旁走入络，并常可夹痰为患。区别言之，肝风内动，因阳气暴张而影响神志；上升颠顶，则见头目诸证；旁窜入络，则见四肢筋脉诸证。

肝风内动，猝然昏倒，不省人事，重者可致一厥不返，手足抽搐、痉挛、强直，半身不遂，口眼斜，两目斜视，脉弦劲。

肝风上冒，头掣痛，眩晕，如坐舟车，行走不稳，耳鸣目花，头摇，甚则出现一时性厥仆，脉弦。

肝风入络，肢体麻木，如有蚁行，肌肉跳动，手足震颤，拘急不利，舌体歪斜抖动，舌强，言语不清，脉细弦。

治疗：肝风内动，当息风潜阳，用羚角钩藤汤，药如石决明、紫贝齿、牡蛎、龙齿、珍珠母、羚羊角（山羊角）、钩藤、天麻；肝风

上冒，当平肝息风，用天麻钩藤饮，药如天麻、钩藤、白蒺藜、桑叶、菊花、蝉衣、珍珠母；肝风入络，当息风和络，用豨莶草、臭梧桐、地龙、全蝎、僵蚕、木瓜。

9. 肾阳不振（命门火衰）与肾气虚弱

包括肾气虚弱、火不暖土等在内。区别言之，肾阳不振的病情较重，全身虚寒现象比较明显；肾气虚弱，主要指肾的封藏与纳气功能失常。

肾阳不振，症见面色苍白，神倦，恶寒，肢冷，腰脊酸冷而痛，腿软，阳痿，早泄，或排尿困难，或见五更泄，下利清谷，舌苔淡白而润，脉沉细迟。

肾气虚弱，一为肾气不固，尿频，甚则不禁，余沥不净，尿浊如泔，滑精，漏精，舌苔淡白，脉细弱；一为肾不纳气，短气喘促，动则喘甚，吸气困难，张口抬肩，咳逆不能平卧，声低气怯，舌质淡隐紫，脉细而虚数。

治疗：肾阳不振，当温补肾阳，用右归丸，药如附子、肉桂、巴戟天、肉苁蓉、淫羊藿、仙茅、鹿角片等。火不暖土，配补骨脂、五味子、肉果。肾气不固，当补肾固摄，用固精丸、缩泉丸之类，药如菟丝子、覆盆子、金樱子、芡实、桑螵蛸、煨益智、龙骨等。有水肿者加怀牛膝、车前子。肾不纳气，当纳气归肾，用人参胡桃汤、参蛤散加五味子、紫河车、沉香、紫石英等。

10. 肾阴亏虚与水亏火旺、相火偏旺

肾阴亏虚是基础，由此引起水亏火旺，或相火偏旺。区别点，肾阴亏虚者，虚象较火旺明显；水亏火旺，为阴不制阳，在阴虚的同时，火旺现象亦显著；相火偏旺为标实的症状比本虚突出，肝肾之火皆亢。

肾阴亏虚，眩晕，耳鸣，目涩，视糊，低热，虚烦，口干咽痛，腰酸腿软，遗精，甚则形体消瘦，舌质红，脉细数。

水亏火旺，同时有明显的面部烘热，颧红，五心烦热，或午后潮热。

相火偏旺，阳兴梦遗，烘热，口苦，颧红，唇赤，小便黄赤灼热，苔黄腻，质红，脉弦数；或头痛，耳鸣，耳聋，急躁易怒，寐差多梦，可伴有某些肾阴虚证。

治疗：肾阴亏虚，当滋养肾阴，用六味地黄汤，药如熟地黄、萸肉、首乌、枸杞子、丹皮、泽泻；水亏火旺，当壮水制火，用生地黄、玄参、天冬、龟板、牡蛎、鳖甲等；相火偏旺，应苦泄相火，用大补阴丸，药如知母、黄柏、生地黄、木通、龙胆草。

第九章 食养疗法

食养疗法起源很早，在中医学形成发展的同时，就有食物治病的记载。周代专设的“食医”，即是专职管理食物补养和饮食卫生的医生。至春秋战国时代，《内经》中明确指出，疾病治疗后应该“谷肉果菜，食养尽之”，以助恢复。后代医家通过临床实践逐步充实内容，并著有食疗专书，如唐朝的《食疗本草》，宋朝的《养老奉亲书》，元朝的《饮膳正要》，清代王孟英的《随息居饮食谱》，都是具有代表性的饮食调养专书，为食养疗法提供了具体而丰富的内容。

一、食养疗法的临床意义

食物是营养人体、维持生命的物质基础，在医疗上亦有较好的预防和治疗作用。有些食物能直接治疗疾病，甚至可以替代药物，属于食疗一类。如黑鱼蒜头汤有温养利水功能，能消退水肿，临床每用以治疗慢性肾炎水肿；藕汁，清热凉血止血，可用以治疗咳血、鼻血等；妇女乳汁减少，喝猪蹄爪汤、虾子汤、酒酿冲鸡蛋等以催发乳汁。有些食物则能补充药物的不足，以辅助治疗。尤其是慢性疾病、体质虚弱者，除药物调治外，更需要食疗辅助，如肺结核、贫血等。故历来就有“药补不如食补”的说法。随着现代科学技术的发展，还发现了有些食物具有较好的防治作用，属于食养一类。如生山楂、红茶、蚕蛹等既可降脂，又能预防动脉硬化；生大蒜头有杀菌、抑制病毒作用，能防治呼吸道、肠道传染病。这些均已为群众所公认和习用。

另一方面也必须注意饮食的偏嗜或偏废、过量不节等对人体也是有害的。如暴饮暴食，易生肠胃病；偏嗜辛辣醇酒，脾胃积热，上可致口腔破溃、牙龈出血，下可致大便干燥或便秘；饮酒日久，易患肝病；吸烟日久，易患肺癌等。至于在患病过程中，饮食配合不当，更会延长病程，影响康复。如慢性气管炎常因吸烟或饮食过咸使咳嗽反复迁延不止，肾炎常因进盐过早或太多而复发。又如小儿患麻疹、百

日咳时，吃过甜或过咸的食物，可以引起哮喘。这些都是必须引起重视的。

二、食养必须注意脾胃功能的强弱

脾胃为仓廪之官、后天之本，饮食必须通过脾胃的受纳、运化，始能变为气血，营养身体，维持生命。因而气血的盛衰既决定于饮食来源，又决定于脾胃功能。食疗能否达到滋养目的，与脾胃功能强弱有关。脾胃功能旺盛时，可以根据疾病需要配合饮食营养，如体虚、贫血严重者，可增加血肉有情之品以补养，适当地选择高蛋白类食物及动物肝脏以补血。若同时脾胃运化功能薄弱，食欲减退，脘腹作胀，大便溏，舌苔厚者，就不能单方面强调“虚者补之”，因饮食太过，增加脾胃负担，反致“虚不受补”。此时只宜用清淡易消化的饮食，配合调理脾胃之药，促进食欲，待脾胃功能恢复后，再予饮食调补。

三、“发物”对疾病的影响

“发物”，是指诱发疾病的食物。这类食物对人体一般没有影响，但对特异素质的个体及某些疾病有影响。这主要是脏腑阴阳平衡失调，对某些食物产生了过敏反应，如鱼、虾、蟹、蕈、笋类、菠菜、雪菜等容易诱发荨麻疹、哮喘等疾病；公鸡、猪头肉动风，往往能引发肝阳头痛、头风等宿疾。

由于“发物”具有催发作用，故临床上有时利用它来辅助治疗，如麻疹透疹前，口服芫荽汤助其透发；种牛痘后，多吃海腥发物催发牛痘。

四、食物与药物的配合

一般来说，食物与药物是有区别的，但药食同源，在功能上都有补泻温清作用。有的既是药又是食，如山楂、大枣、胡桃肉、萝卜、白果、首乌、茯苓、山药等即属此类。故药物与食物配合恰当，可以增强疗效，若食性与药性相反而作用相互抵消者，则应忌用。如服伐木丸时就须忌饮茶，因茶叶内含有鞣质可以消除针砂之效。但临床上也往往利用其相反、相制作用来治疗疾病，如气虚腹胀，用人参配莱菔子（或萝卜），使人参补气而不滞气，莱菔子行气而不耗气，以达到补气消胀的治疗目的。

五、根据疾病证候要求掌握饮食宜忌

食物作用与疾病证候属性有着密切的关系，要发挥食物的作用就必须根据疾病证候要求掌握饮食宜忌。原则上阳虚、寒证疾病，禁忌生冷寒凉食物；阴虚、热证疾病，忌辛辣烟酒及其他热性食物。寒证宜温，如姜、椒、葱、蒜、酒类；热证宜凉，如瓜果、马兰头、菊花头等。虚者补之，需别阴阳。阴虚宜清补，如百合、甲鱼、淡菜、海参、银耳；阳虚宜温补，如羊肉、狗肉、牛肉类。在此基础上，结合脏腑病变部位配予适当的饮食，采用以脏补脏的脏器疗法，如肺病以肺补之，胃病用猪肚，肾病用猪腰，糖尿病用猪胰，甲状腺用羊靥（即羊的甲状腺），贫血、目疾用猪肝等。如用猪肺与冬虫夏草合煮治疗肺结核；猪肚内塞生姜、红糖煮烂，治疗胃脘痛；腰子与杜仲煨汤治疗肾虚腰痛等。这些单方验方，常能取得一定的效果。

六、饮食的烹调方法与治病的关系

饮食的烹调加工，既要根据食物的品种，更重要的是适应疾病需要。对胃肠病患者，鸡鸭等禽畜肉类要用文火煮烂，以利于消化吸收；老年、婴幼儿无牙患者，应将食物制成流质、糊状不同类型的烂软饮食。至于油炸火烤类的鱼肉，易致脾胃积热，助火生痰，日久可以形成噎膈，故健康人亦少吃为宜。据目前所知，烧焦的鱼肉，构成其蛋白质的氨基酸易形成 γ -氨基甲衍生物，是强烈的致癌物，其强度

超过黄曲霉素。这符合中医学认为噎膈与多食油煎炙烤物有关的经验。

最后要说的是，现代用膏方为补者甚嚣尘上，但应有宜忌两面。脾虚不健，虚不受补，不可壅补、蛮补。还要注意体质差异、有无宿积，避免补不得法，反而碍胃。

代谢紊乱者，不可再补，如高脂血症、糖尿病等，应忌用糖、豆制品等。



责任编辑 肖培新
封面设计 刘洪利

本书为南京中医药大学教授、国医大师周仲瑛先生的著作，为周仲瑛教授六十多年临床带教的教学心得。

本书共分九章，针对中医医学生或中医初学者初入临床的具体情况，分别论述了病历要求、四诊的临床应用、辨证要领、治法方略、选方要点、临证选药、常用药物的配伍、常用脏腑病机类证辨治及食养疗法。

读中医药书，走健康之路
扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



中医出版
(zhongyichuban)



悦读中医
(ydzhongyi)

上架建议：中医学术



定价：19.00元



Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.sk

z-lib.gs

z-lib.fm

go-to-library.sk



[Official Telegram channel](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Library>